

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 19 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 6
Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points) 7
Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points) 9
Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points) 11
Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points) 12
Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points) 13
Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points) 14
Corrigés de la partie 1 16
Partie 2 – Sources et outils de la veille 17
Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points) 19
Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points) 21
Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points) 23
Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points) 24
Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points) 25
Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points) 27
Corrigés de la partie 2 29
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 30
Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points) 32
Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points) 33
Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points) 34
Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points) 36
Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points) 37
Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points) 39
Corrigés de la partie 3 40
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 42
Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points) 43
Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points) 45
Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points) 46
Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points) 47
Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points) 48
Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points) 50
Corrigés de la partie 4 52
Partie 5 – La publication scientifique 53
Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points) 55
Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points) 57
Exercice 19.27 – Le DOI (12 points) 59
Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points) 60
Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points) 61
Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points) 62
Corrigés de la partie 5 64
Partie 6 – Lire une étude selon son type 65
Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points) 67
Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points) 69
Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points) 71
Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points) 72
Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points) 73

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points) 75
Corrigés de la partie 6 77

Partie 7 – Du résultat à l'information du public 78
Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points) 80
Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points) 82
Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points) 84
Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points) 85
Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points) 86
Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points) 87
Corrigés de la partie 7 88

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 90
Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points) 91
Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points) 92
Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points) 93
Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points) 94
Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points) 95
Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points) 97
Corrigés de la partie 8 102

Bilan : grille d'auto-évaluation 106

Cahier d'exercices – Chapitre 19

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 19 : la veille scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale et institutionnelle ; ses étapes et ses outils ; les ressources (organismes internationaux, européens, nationaux, professionnels) ; la base documentaire, la diffusion ciblée et l'évaluation de la veille ; la fiabilité de l'information ; le circuit de publication, les revues prédatrices et les conflits d'intérêts ; la lecture critique d'un article et de sa présentation dans les médias (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de la veille, les formes de veille, les outils, les ressources, la fiche de la base documentaire, la fiabilité d'une source, le circuit d'un article, la grille de lecture critique, les niveaux de preuve, les signaux d'une revue prédatrice, la diffusion ciblée.
- Calculer et interpréter : volume et temps de veille, taux de pertinence, de diffusion et d'utilisation, coût d'une veille, scores de fiabilité, délais entre publication et application d'un texte, perdus de vue, risque absolu et risque relatif, variation relative, fréquences naturelles, conversion de doses.
- Organiser, présenter et défendre une veille, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'articles, extraits de presse), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, bilans de veille, articles, résumés d'études, communiqués, messages et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels, les publications et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Veiller et lire de façon critique

Avant de chercher, écrivez **ce que vous voulez savoir** et **pour qui**. Choisissez peu de sources, fiables et complémentaires, et laissez les outils vous apporter l'information. Pour chaque information, notez **qui** l'a produite, **quand**, **comment** (type d'étude, effectifs) et **avec quel intérêt**. Séparez toujours ce que le document **montre** de ce qu'il **affirme**. Diffusez peu, mais utile, avec la source et la date, et mesurez ce qui sert vraiment.

Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la veille et la distinguer d'une recherche documentaire ponctuelle.
- Citer et ordonner les étapes du cycle de la veille.
- Classer une information selon la forme de veille.
- Traduire un besoin d'équipe en axes et en questions de veille.
- Analyser une demande de veille dans une structure professionnelle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement, pour repérer, analyser et diffuser les informations utiles, afin d'**anticiper** et de **décider**.
- La **recherche documentaire** répond à une question précise, à un moment donné ; la **veille** surveille un sujet dans la durée ; la **bibliographie** est la liste des références citées dans un document.
- **Formes** de veille : scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle (et technologique).
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse (avec stockage), diffusion, évaluation ; puis on recommence.
- Un **axe de veille** est un sujet ; une **question de veille** dit ce que l'on veut savoir sur ce sujet, pour qui et pour quoi faire.

Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la veille à un nouveau diététicien d'un service de restauration municipale (structure fictive). Il vous dit : « La veille, c'est lire les nouvelles le matin, non ? »

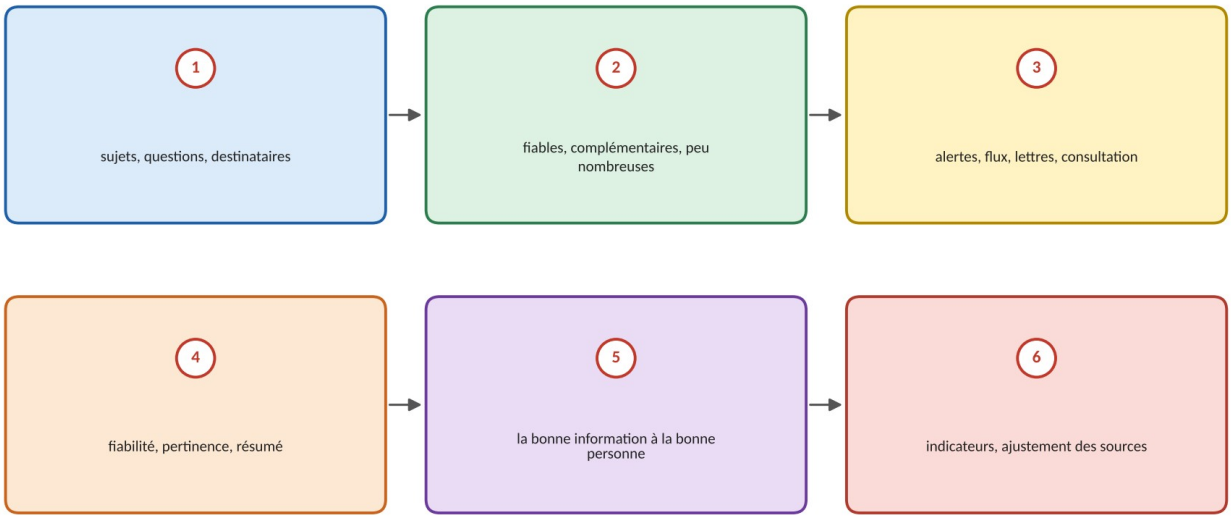


Figure 19.1 – Document 1 – Le cycle de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Donnez une définition de la veille en une phrase, avec les mots « continue » et « organisée ». (2 pts)

3. Expliquez pourquoi l'étape « besoins » vient avant l'étape « sources ». (2 pts)

4. Expliquez pourquoi le cycle se referme sur l'étape 1 et ce qui peut changer à chaque tour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un groupement d'EHPAD (structure fictive) a noté huit informations reçues en une semaine. Elle vous demande de les classer.

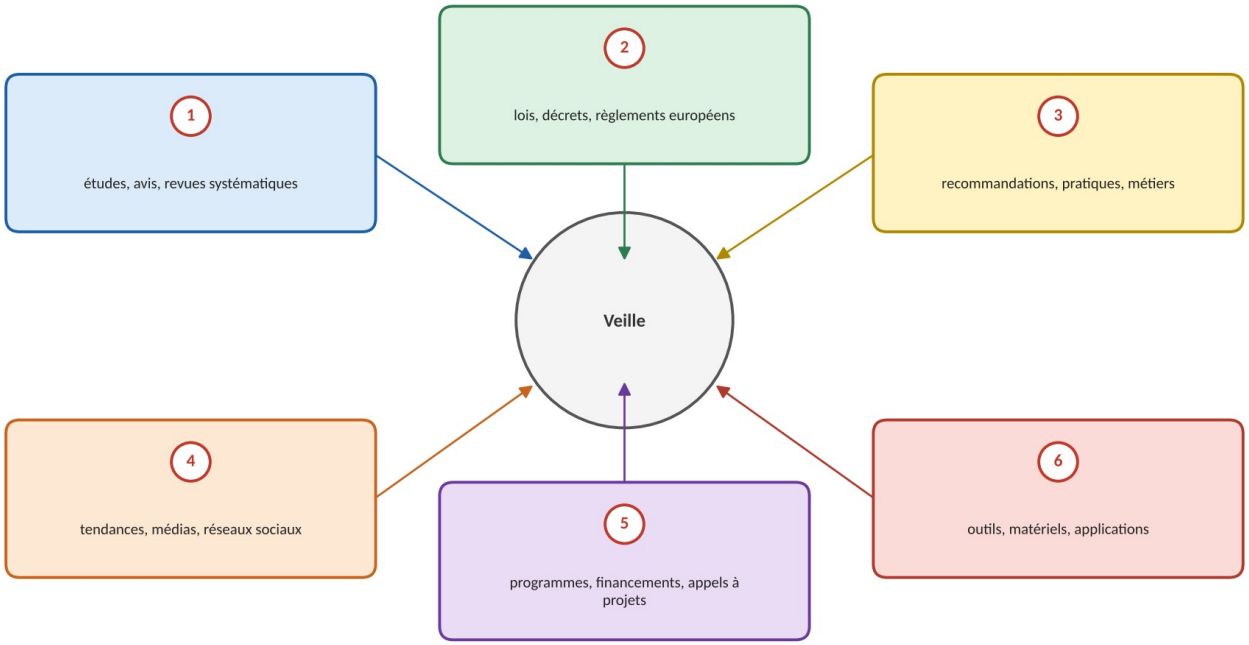


Figure 19.2 – Document 1 – Les formes de veille (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine

- **A.** Un nouveau décret modifie les règles de qualité nutritionnelle des repas en restauration collective.
- **B.** Une revue systématique sur la dénutrition de la personne âgée est publiée.
- **C.** L'ARS lance un appel à projets « Bien vieillir à domicile ».
- **D.** Une vidéo sur un « régime anti-âge » est très partagée par les familles des résidents.
- **E.** La HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition.
- **F.** Un fournisseur présente une application de commande des repas sur tablette.
- **G.** Un congrès de diététiciens consacre une journée aux textures modifiées.
- **H.** Une enquête d'opinion montre que les Français s'intéressent de plus en plus au « fait maison ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit informations du document 2 selon la forme de veille. Une information peut relever de deux formes : justifiez alors. (6 pts)
3. Pour les informations A et D, dites à qui la diététicienne doit les transmettre et avec quel délai. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a mis en place une veille sur l'alimentation des sportifs pour un service des sports universitaire (structure fictive). Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de la veille, dans le désordre

- **A.** Supprimer une alerte qui n'apporte que des publicités pour des compléments.
- **B.** Demander aux entraîneurs et au médecin quelles questions ils se posent.
- **C.** S'abonner aux lettres d'information de l'ANSES et de l'INSEP.
- **D.** Lire chaque lundi les titres et résumés reçus, et en garder quelques-uns.
- **E.** Créer une alerte PubMed sur *sports nutrition AND students*.
- **F.** Envoyer une note mensuelle d'une page aux entraîneurs.
- **G.** Ranger chaque information retenue dans un tableur, avec des mots-clés.
- **H.** Compter, après trois mois, les informations utilisées par les entraîneurs.
- **I.** Choisir trois axes : hydratation, compléments alimentaires, repas avant la compétition.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)
2. Associez chaque tâche à une étape du cycle de la veille. (4 pts)
3. La tâche A arrive après la tâche H : expliquez pourquoi c'est logique. (2 pts)
4. Proposez une tâche manquante qui améliorerait la diffusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage dans une association de lutte contre la précarité alimentaire (structure fictive), vous entendez trois mots employés l'un pour l'autre : veille, recherche documentaire, bibliographie.

Document 1 – Six situations

- **A.** Vous cherchez, en une après-midi, ce que l'on sait sur les ateliers cuisine pour des familles en précarité, pour rédiger l'introduction de votre dossier.
- **B.** Vous recevez chaque mois les publications de la Drees et de l'Observatoire des inégalités et en transmettez l'essentiel.
- **C.** Vous listez à la fin de votre dossier les 14 documents que vous avez cités.
- **D.** Vous suivez, pendant tout le stage, les textes sur la lutte contre la précarité alimentaire.
- **E.** Vous vérifiez une seule fois la teneur en fibres des lentilles dans la table Ciqual.
- **F.** Vous surveillez les questions posées sur le forum des bénévoles pour repérer les idées reçues.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque situation : veille, recherche documentaire ponctuelle ou bibliographie. (6 pts)

2. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire. (3 pts)

3. Expliquez comment une veille bien tenue facilite la rédaction de la bibliographie du dossier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un lycée professionnel (fictif) de 650 élèves, dont 210 internes, veut mettre en place une veille. Le gestionnaire vous transmet les remarques de l'équipe.

Document 1 – Les remarques de l'équipe

- Le chef de cuisine : « On change sans arrêt les règles sur les produits durables et bio, je ne sais jamais ce qui s'applique. »
- L'infirmière : « Les internes me parlent de boissons énergisantes et de régimes vus sur les réseaux. »
- La gestionnaire : « Il paraît qu'il existe des aides pour acheter local. »
- Le CPE : « On voudrait des idées d'animations sur l'alimentation pour l'internat. »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille, un par remarque, et la forme de veille de chacun. (4 pts)

2. Pour chaque axe, rédigez une question de veille qui précise ce que l'on veut savoir, pour qui et pour quoi faire. (6 pts)

3. Pour chaque axe, indiquez la fréquence de diffusion la plus adaptée et justifiez. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans le service diététique d'un centre hospitalier (fictif) qui compte 6 diététiciennes. La cadre de santé vous dit : « Chacune fait sa veille dans son coin. On reçoit tous les mêmes lettres, on rate les recommandations importantes, et personne ne sait qui a lu quoi. Proposez-nous une organisation commune. »

Document 1 – L'état des lieux (enquête rapide auprès des 6 diététiciennes, fictive)

	Diététicienne 1	2	3	4	5	6
Lettres d'information reçues	12	9	15	7	11	10
Dont lettres reçues aussi par au moins une autre diététicienne	9	8	11	6	8	8
Temps de veille par semaine (min)	90	30	120	20	60	40
Spécialité	Néphrologie	Pédiatrie	Diabétologie	Gériatrie	Oncologie	Nutrition artificielle

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'abonnements, le nombre et la part d'abonnements en doublon, et le temps total de veille du service par semaine. (4 pts)
2. Relevez trois dysfonctionnements et leurs conséquences pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Proposez une organisation commune : répartition des axes, outils partagés, rythme de diffusion. Estimez le temps hebdomadaire nécessaire si chaque diététicienne consacre 25 minutes à son axe et que la synthèse mensuelle demande 2 heures. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la nouvelle organisation au bout de six mois. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 19.1

1. Légendes : 1 Besoins ; 2 Sources ; 3 Collecte ; 4 Tri et analyse ; 5 Diffusion ; 6 Évaluation.
2. La veille est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) qui permet de repérer, d'analyser et de diffuser les informations utiles, pour anticiper et décider.
3. On ne peut pas choisir de bonnes sources sans savoir **ce que l'on cherche** et **pour qui** : un chef de cuisine a besoin de textes réglementaires, une diététicienne de recommandations scientifiques. Sans besoins définis, on s'abonne à tout et l'on est noyé.
4. Le cycle est **continu** : l'évaluation montre ce qui a servi et ce qui n'a pas servi. À chaque tour, on peut changer les **besoins** (nouveau projet, nouvelle question de l'équipe), supprimer ou ajouter des **sources**, modifier une **alerte** trop large, changer la **forme** de diffusion. Répondre au diététicien : lire les nouvelles le matin, c'est de l'information au hasard ; la veille choisit, trie, range, diffuse et s'évalue.

Corrigé – Exercice 19.2

1. Légendes : 1 Scientifique ; 2 Réglementaire ; 3 Professionnelle ; 4 Sociétale ; 5 Institutionnelle ; 6 Technologique.
2. A : **réglementaire**. B : **scientifique**. C : **institutionnelle** (programme, financement). D : **sociétale** (ce qui circule auprès des familles). E : **professionnelle** (recommandation de bonne pratique) et **scientifique** (elle s'appuie sur une revue des preuves). F : **technologique** (outil numérique). G : **professionnelle** (pratiques, formation). H : **sociétale** (tendance d'opinion).
3. A : au directeur et au responsable de cuisine, **rapidement**, avec la date d'entrée en vigueur, car il faut adapter les menus et les marchés. D : à l'équipe soignante et à l'animatrice, dans la **note mensuelle**, avec une réponse type pour les familles ; immédiatement si la vidéo pousse à un régime dangereux pour des résidents fragiles (risque de dénutrition).

Corrigé – Exercice 19.3

1. Ordre : **B – I – C – E – D – G – F – H – A**.
2. Besoins : B, I ; sources : C ; collecte : E ; tri et analyse : D, G (stockage) ; diffusion : F ; évaluation : H ; ajustement (nouveau tour du cycle) : A.
3. C'est l'**évaluation** (H) qui montre que l'alerte n'a rien apporté d'utile : on la supprime ensuite (A). Supprimer une source avant de l'avoir évaluée, c'est décider sans données.
4. Exemples : présenter oralement deux informations à la réunion mensuelle des entraîneurs ; préparer une fiche d'une page « Les compléments : ce qu'il faut savoir » à afficher au vestiaire ; demander aux entraîneurs quel format ils préfèrent.

Corrigé – Exercice 19.4

1. A : **recherche documentaire** ponctuelle. B : **veille** (institutionnelle et sociale, continue). C : **bibliographie**. D : **veille** réglementaire. E : **recherche** ponctuelle d'une donnée. F : **veille** sociétale.
2. La veille est **continue** (elle dure tout le stage ou toute l'année) alors que la recherche documentaire est **ponctuelle** ; la veille **surveille un sujet** et repère les nouveautés, la recherche **répond à une question** précise ; la veille s'appuie sur des outils qui apportent l'information (alertes, flux), la recherche sur des requêtes dans des bases.
3. Chaque information retenue est rangée avec sa **référence complète**, sa date et sa date de consultation : il suffit de reprendre les références utilisées dans le dossier, déjà vérifiées. Un logiciel de gestion de références produit la bibliographie dans le style choisi.

Corrigé – Exercice 19.5

1. Axes : **règles des achats en restauration collective** (réglementaire) ; **boissons énergisantes et régimes à la mode chez les adolescents** (sociétale et scientifique) ; **financements et aides à l'achat local** (institutionnelle) ; **outils d'éducation à l'alimentation pour adolescents** (professionnelle).
2. Exemples : « Quelles obligations d'achat de produits durables et bio s'appliquent au lycée, à partir de quelle date, pour adapter les marchés et les menus ? » ; « Que disent les sources fiables sur les boissons énergisantes et les régimes vus par les internes, pour que l'infirmière puisse leur répondre ? » ; « Quelles aides publiques (région, État, projet alimentaire territorial) peuvent financer l'achat local, pour que la gestionnaire dépose un dossier ? » ; « Quels outils d'animation validés existent pour des adolescents, pour que le CPE construise des soirées à l'internat ? »
3. Réglementaire : **dès parution** pour un texte qui change les obligations, avec un point trimestriel ; sociétal : **mensuel**, plus une réponse rapide si une tendance dangereuse apparaît ; institutionnel : **à chaque appel à projets**, car les délais de dépôt sont courts ; professionnel : **trimestriel**, en préparant l'année scolaire.

Corrigé – Exercice 19.6

1. Abonnements : 12 + 9 + 15 + 7 + 11 + 10 = **64**. En doublon : 9 + 8 + 11 + 6 + 8 + 8 = **50**, soit 50 / 64 = **78,1 %**. Temps total : 90 + 30 + 120 + 20 + 60 + 40 = **360 min**, soit **6 h par semaine** pour le service.
2. Exemples : **doublons** (les mêmes lettres lues six fois : temps perdu) ; **temps très inégal** (20 à 120 minutes) : certaines spécialités sont peu surveillées ; **aucun partage** : une recommandation lue par l'une n'arrive pas aux autres, d'où des conseils différents aux patients et un risque de pratiques non actualisées ; **pas de trace** de ce qui a été lu.
3. Organisation : chaque diététicienne surveille l'**axe de sa spécialité** et une source commune lui est attribuée (par exemple : HAS pour l'une, ANSES pour une autre) ; un **tableur partagé** unique (date, source, axe, résumé, intérêt, diffusé) ; une **synthèse mensuelle** présentée en 15 minutes à la réunion de service ; une transmission immédiate pour une recommandation majeure. Temps : 6 × 25 = 150 min par semaine, plus 2 h par mois, soit environ 120 / 4 = 30 min par semaine : **180 min par semaine**, la moitié du temps actuel.
4. Exemples : **nombre de doublons** d'abonnements (objectif : aucun) ; **temps total** de veille par semaine ; **nombre d'informations utilisées** dans les pratiques (protocoles, documents patients) en six mois ; **satisfaction** de l'équipe (questionnaire court).

Partie 2 – Sources et outils de la veille

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les outils « push » et « pull » de la veille.
- Associer une question professionnelle à l'organisme de référence qui y répond.
- Régler une alerte pour réduire le bruit sans perdre l'essentiel.
- Estimer le temps de lecture d'une veille et le réduire.
- Distinguer la date d'un texte et sa date d'application.
- Choisir les sources d'une veille pour une structure donnée.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Push** : l'information vient à moi (alerte, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion). **Pull** : je vais la chercher (consultation régulière de sites).

- Une **alerte** est une requête enregistrée qui envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
- Le **bruit** est l'ensemble des résultats inutiles ; le **silence** est l'ensemble des documents utiles que l'on n'a pas reçus.
- Ressources de référence : OMS et FAO (monde) ; Codex Alimentarius (normes) ; EFSA (Europe) ; ANSES, Santé publique France, HAS (France) ; AFDN et sociétés savantes (profession).
- Un texte a une **date de signature**, une **date de publication** et une ou plusieurs **dates d'application** : c'est la date d'application qui compte pour les pratiques.

Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) installée depuis un an dit : « Je passe mes soirées à visiter des sites un par un, et j'oublie toujours d'en regarder certains. »



Figure 19.3 – Document 1 – Les outils de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez les six outils en deux groupes : « push » et « pull ». Définissez ces deux mots. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la méthode de la diététicienne est coûteuse et peu fiable. (2 pts)

4. Proposez-lui deux outils « push » adaptés, avec un exemple précis pour chacun. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cuisine centrale (fictive) qui prépare des repas pour des écoles et des personnes âgées, l'équipe se pose des questions très variées. Vous devez indiquer, pour chacune, l'organisme de référence à surveiller.

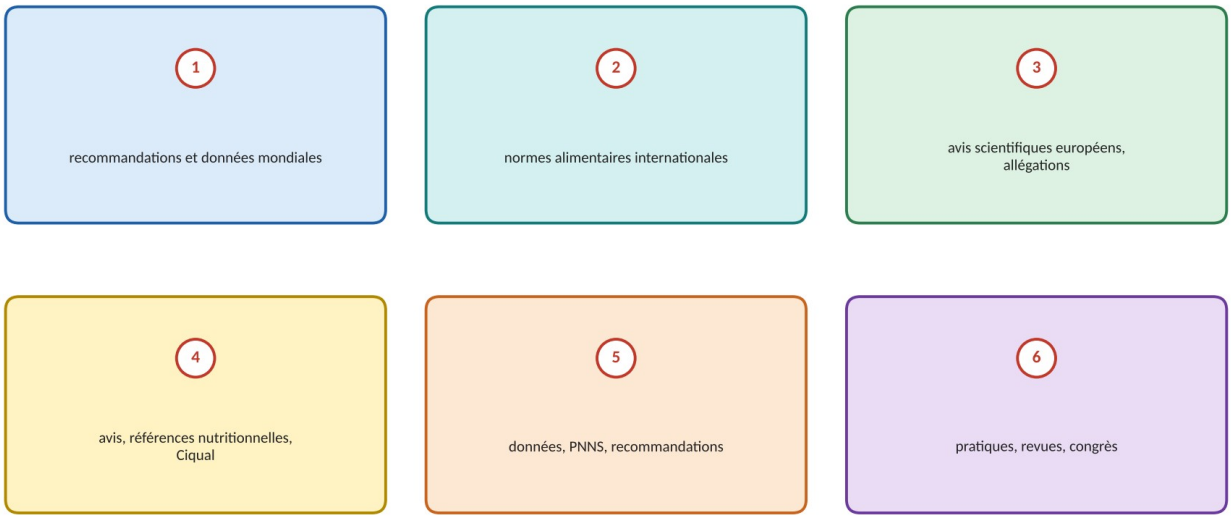


Figure 19.4 – Document 1 – Les ressources de la veille (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

- **A.** Quelle est la teneur en fer des lentilles vertes cuites ?
- **B.** Une allégation « riche en fibres » est-elle autorisée sur nos biscuits maison vendus à la kermesse ?
- **C.** Quelle est la norme internationale pour une catégorie d'aliment exporté ?
- **D.** Quelles sont les recommandations actuelles sur les fruits et légumes pour les adultes en France ?
- **E.** Comment diagnostiquer la dénutrition chez une personne âgée ?
- **F.** Quelles sont les pratiques des autres diététiciens en restauration scolaire ?
- **G.** Quelle est la recommandation mondiale sur la limitation des sucres libres ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, indiquez l'organisme le plus adapté et justifiez en une phrase. (7 pts)
3. Expliquez pourquoi on préfère la source d'origine (l'organisme) à un article de presse qui la résume. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de diabétologie (fictif) a créé une alerte PubMed sur l'alimentation et le diabète de type 2. Elle reçoit trop d'articles et a cessé de les lire. Vous testez des filtres successifs.

Document 1 – Les effets des filtres (données fictives, par an)

Étape	Filtre appliqué	Part conservée à cette étape
Requête brute	type 2 diabetes AND diet	2 500 articles par an
Filtre 1	études chez l'humain	72 %
Filtre 2	articles en anglais ou en français	90 %
Filtre 3	essais randomisés, revues systématiques, méta-analyses	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'articles conservés après chaque filtre, puis la part finale par rapport à la requête brute. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'articles reçus par semaine (52 semaines) avant et après les filtres, puis le temps de lecture des titres et résumés à raison de 2 minutes par article. (4 pts)
3. Le filtre 3 réduit le bruit mais peut créer du silence : expliquez avec un exemple. (2 pts)
4. Proposez une façon de ne pas perdre les études importantes exclues par le filtre 3. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un diététicien d'un réseau de santé (fictif) suit 14 flux RSS dans un agrégateur. Il parcourt chaque titre en 30 secondes en moyenne. Il retient en moyenne 10 articles par semaine et lit le résumé de chacun en 3 minutes.

Document 1 – Les articles reçus par semaine, par flux (données fictives)

Flux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Articles par semaine	35	22	18	12	9	8	6	5	4	3	2	2	1	1

Les flux 1, 2 et 3 sont des rubriques « santé » de sites d'information générale. Sur les trois derniers mois, aucun article retenu n'en provenait.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'articles reçus par semaine et le temps hebdomadaire de veille (titres et résumés). (3 pts)
2. Calculez la part des articles qui viennent des flux 1, 2 et 3. (2 pts)
3. Calculez le nouveau temps hebdomadaire si l'on supprime ces trois flux, sans changer le nombre d'articles retenus. Concluez. (4 pts)
4. Avant de supprimer un flux, quelle vérification faut-il faire ? Proposez aussi une règle simple de suppression des flux. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un responsable de restauration collective vous dit : « Ce règlement date de 2011, il est donc appliqué depuis 2011. Et la loi EGalim, c'est 2018, on avait jusqu'en 2018 ! » Vous reprenez les dates avec lui.

Document 1 – Quatre textes et leurs dates

Texte	Date du texte	Publication	Application
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO » (information du consommateur)	25 octobre 2011	JOUE du 22 novembre 2011	13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire au 13 décembre 2016
Loi n° 2018-938 « EGalim »	30 octobre 2018	JO du 1er novembre 2018	au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Loi n° 2021-1104 « Climat et résilience »	22 août 2021	JO du 24 août 2021	extension des objectifs à la restauration collective privée au 1er janvier 2024
Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations)	20 décembre 2006	JOUE de décembre 2006, rectifié en janvier 2007	1er juillet 2007

Sources : EUR-Lex et Légifrance, textes consultés en octobre 2026.

À vous de jouer – Questions

1. Pour le règlement INCO, calculez le délai entre la publication et chacune des deux dates d'application, en années et en mois. (3 pts)
2. Pour EGalim, calculez le délai entre la publication et l'objectif de 2022. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un texte prévoit souvent un délai avant son application. (3 pts)
4. Corrigez les deux phrases du responsable. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi, sur Légifrance, il faut lire la **version consolidée** d'une loi et regarder sa date de mise à jour. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) suit 380 patients diabétiques de type 2. Elle organise des ateliers d'éducation thérapeutique. Le médecin coordinateur vous demande : « Quelles sources suivre, sans y passer plus d'une heure par semaine ? » Il vous transmet la liste proposée par un collègue.

Document 1 – La liste proposée par un collègue

- **A.** Le compte d'un influenceur « nutrition » qui publie chaque jour.
- **B.** Les recommandations de la HAS sur le diabète de type 2.
- **C.** Une alerte PubMed sur *type 2 diabetes* sans aucun filtre.
- **D.** La lettre d'information de la Fédération française des diabétiques.
- **E.** Le site d'un laboratoire qui vend un complément « régulateur de glycémie ».
- **F.** Le site de la Société francophone du diabète (recommandations, congrès).
- **G.** La table Ciqual de l'ANSES.
- **H.** Les publications de Santé publique France sur le diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque source, dites si vous la gardez, la modifiez ou la retirez, et justifiez. (8 pts)
2. Pour chaque source gardée, indiquez l'outil (alerte, RSS, lettre, consultation) et la fréquence. (4 pts)
3. Montrez que votre plan tient en une heure par semaine, en estimant le temps de chaque source. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 19.7

1. Légendes : 1 Alerte sur une base ; 2 Alerte de moteur ; 3 Flux RSS ; 4 Lettre d'information ; 5 Liste de diffusion ; 6 Consultation de sites.
2. **Push** (l'information arrive sans que je la demande à chaque fois) : alerte sur une base, alerte de moteur, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion. **Pull** (je vais chercher l'information) : consultation de sites.
3. Visiter les sites un par un prend beaucoup de **temps**, sans savoir s'il y a du nouveau ; on **oublie** des sites ; on ne garde **aucune trace** de ce qui a été vu. La veille dépend de la mémoire et de la fatigue.
4. Exemples : s'abonner à la **lettre d'information** de l'ANSES et à celle de la HAS ; créer une **alerte PubMed** sur un sujet de sa pratique (par exemple *irritable bowel syndrome AND diet*) ; regrouper les **flux RSS** des sites de référence dans un agrégateur. On garde la consultation directe pour les quelques sites sans lettre ni flux.

Corrigé – Exercice 19.8

1. Légendes : 1 OMS et FAO ; 2 Codex Alimentarius ; 3 EFSA ; 4 ANSES ; 5 Santé publique France et HAS ; 6 AFDN et sociétés savantes.
2. A : **ANSES**, qui publie la table de composition Ciqual. B : **EFSA** pour l'avis scientifique et le **registre de l'Union européenne** des allégations autorisées (règlement n° 1924/2006). C : **Codex Alimentarius**, qui fixe les normes alimentaires internationales (FAO et OMS). D : **Santé publique France** (recommandations du PNNS, « Manger Bouger »), qui s'appuie sur les avis de l'ANSES. E : **HAS**, qui publie les recommandations de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition. F : **AFDN** et réseaux de diététiciens (revues, congrès, groupes de travail). G : **OMS** (lignes directrices de 2015 sur les sucres).
3. Un article de presse est une **source secondaire** : il peut résumer mal, simplifier, citer une version ancienne ou ajouter un titre accrocheur. La source d'origine donne le **texte exact**, la **date**, les **conditions** et les **limites**. On peut lire la presse pour être alerté, puis on **vérifie** toujours à la source.

Corrigé – Exercice 19.9

1. Après le filtre 1 : 2 500 × 0,72 = **1 800**. Après le filtre 2 : 1 800 × 0,90 = **1 620**. Après le filtre 3 : 1 620 × 0,15 = **243** articles par an. Part finale : 243 / 2 500 = **9,7 %** de la requête brute (on peut aussi faire 0,72 × 0,90 × 0,15 = 0,0972).
2. Avant : 2 500 / 52 ≈ **48 articles par semaine**, soit 48,1 × 2 ≈ **96 min** (plus d'une heure et demie). Après : 243 / 52 ≈ **4,7 articles par semaine**, soit environ **9 min**. La veille redevient tenable.
3. Le filtre 3 ne garde que certains types d'études. Il exclut par exemple une **grande cohorte** sur la consommation de boissons sucrées et le risque de diabète, ou une **recommandation** d'une société savante : ce sont des documents utiles que l'on ne reçoit plus, c'est du **silence**.
4. Exemples : créer une **deuxième alerte**, mensuelle, sans le filtre 3 mais limitée aux titres (*[ti]*) ; suivre en plus les **recommandations** (HAS, sociétés savantes) par leurs lettres d'information ; tester l'alerte une fois par an en vérifiant qu'elle retrouve les grandes publications connues de l'année.

Corrigé – Exercice 19.10

1. Total : 35 + 22 + 18 + 12 + 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = **128 articles par semaine**. Titres : 128 × 0,5 = 64 min ; résumés : 10 × 3 = 30 min ; total : **94 min par semaine**.
2. Flux 1, 2 et 3 : 35 + 22 + 18 = 75 articles, soit 75 / 128 = **58,6 %** des articles reçus.
3. Il reste 128 − 75 = 53 articles : 53 × 0,5 = 26,5 min de titres, plus 30 min de résumés, soit **56,5 min par semaine**. Le gain est de 37,5 min par semaine (environ 40 %), sans perdre d'article retenu : ces trois flux étaient du **bruit**.

4. Vérifier que les informations utiles de ces flux sont bien **reçues par une autre source** (par exemple, l'information vient en réalité d'un communiqué de l'ANSES, déjà suivie). Règle : tous les trois mois, on supprime un flux dont **aucun article n'a été retenu** pendant la période, et l'on note la suppression dans le plan de veille.

Corrigé – Exercice 19.11

1. INCO : du 22 novembre 2011 au 13 décembre 2014, environ **3 ans** (3 ans et 21 jours) ; jusqu'au 13 décembre 2016, environ **5 ans** (5 ans et 21 jours).
2. EGalim : du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2022, **3 ans et 2 mois**.
3. Les professionnels doivent avoir le temps de **s'adapter** : changer les étiquettes et écouler les stocks (INCO), modifier les **marchés publics** et trouver des fournisseurs (EGalim), former les équipes, adapter les logiciels. Un texte peut aussi prévoir **plusieurs étapes** d'application.
4. « Le règlement INCO date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014, et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016. » « La loi EGalim date de 2018, mais l'objectif de 50 % de produits durables, dont 20 % de bio, s'applique en restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; la loi Climat et résilience l'a étendu à la restauration collective privée au 1er janvier 2024. »
5. Une loi est **modifiée** par des lois suivantes (EGalim a été modifiée par la loi Climat et résilience, par exemple). Le texte d'origine (« version initiale ») ne dit donc plus ce qui s'applique. La **version consolidée** intègre toutes les modifications à une date donnée. On note cette **date de consultation** dans la base de veille, et l'on vérifie à chaque diffusion qu'aucune nouvelle modification n'est parue.

Corrigé – Exercice 19.12

1. A : **retirer** ; aucune garantie de compétence ni de méthode, publication quotidienne qui crée du bruit (on peut la regarder à part, en veille sociétale, pour connaître les idées reçues des patients). B : **garder** ; recommandations de référence en France. C : **modifier** ; sans filtre, plusieurs milliers d'articles par an : ajouter des filtres (humain, types d'études, *diet* ou *education*). D : **garder** ; association de patients, utile pour connaître les préoccupations des patients et les actions locales. E : **retirer** ; source commerciale en conflit d'intérêts. F : **garder** ; société savante, recommandations et congrès. G : **garder**, mais en **consultation** au besoin (c'est une table de données, pas une source de nouveautés), avec une alerte sur les nouvelles versions. H : **garder** ; données épidémiologiques et campagnes.
2. B : lettre d'information de la HAS, à réception. C : alerte PubMed filtrée, hebdomadaire. D : lettre d'information, mensuelle. F : flux RSS ou lettre, mensuel, et programme du congrès annuel. G : consultation au besoin. H : lettre ou flux RSS, mensuel.
3. Estimation par semaine : alerte PubMed filtrée, 5 articles × 2 min = 10 min ; lettres HAS, Fédération, SPF : 3 × 5 min = 15 min ; société savante : 5 min ; tri, rangement dans la base : 10 min ; préparation d'une courte note pour l'équipe : 15 min. Total : **55 min**, sous l'heure demandée (estimations à vérifier au bout d'un mois).

Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire la fiche d'une information dans une base documentaire.
- Choisir des mots-clés dans une liste fermée et repérer les doublons.
- Cibler la diffusion d'une information : qui, quoi, pourquoi, comment, quand.

- Rédiger une note de veille courte et utile.
- Calculer et interpréter des indicateurs d'évaluation de la veille.
- Estimer le coût d'une veille et comparer deux organisations.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une fiche de la base contient : **référence** complète, **mots-clés**, **résumé** de deux lignes, **intérêt** pour la structure, **usage** (diffusé à qui, utilisé comment).
- Une **liste fermée** de mots-clés (un thésaurus maison) évite les synonymes et permet de retrouver une information.
- Diffuser, c'est répondre à cinq questions : **qui, quoi, pourquoi, comment, quand**. On diffuse **peu**, **ciblé** et **daté**.
- Une **note de veille** tient sur une page : titre, date, trois à cinq informations, chacune avec sa source et « ce que cela change pour nous ».
- On évalue la veille par des **indicateurs** de moyens (temps, coût), d'activité (informations retenues, diffusées, délais) et de résultat (informations utilisées, satisfaction).

Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de rééducation (fictif) range ses informations dans un dossier de favoris de son navigateur, sans aucune note. Elle ne retrouve plus un article lu il y a six mois.

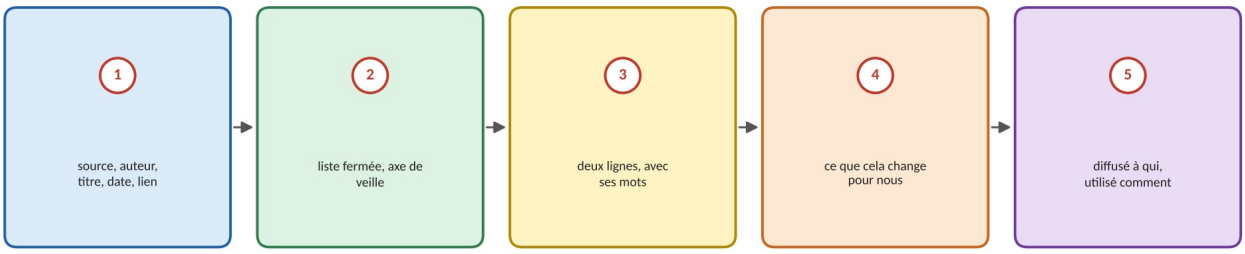


Figure 19.5 – Document 1 – La fiche d'une information dans la base documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un simple favori ne suffit pas. Donnez deux raisons. (2 pts)
3. Remplissez une fiche complète pour l'information suivante : la HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée ; votre centre accueille surtout des personnes de plus de 70 ans après une fracture. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réseau des diététiciens d'un département (fictif) partage depuis deux ans un tableur de veille. Chacun y ajoute ses informations avec ses propres mots-clés. Vous faites le bilan.

Document 1 – Le bilan du tableur (données fictives)

- 420 lignes, dont 63 sont des doublons (la même information saisie par deux personnes).
- 118 mots-clés différents utilisés.
- Exemples de mots-clés : « dénutrition », « dénutri », « malnutrition », « perte de poids involontaire », « PA », « personne âgée », « seniors », « sujet âgé », « EHPAD », « maison de retraite ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons et le nombre d'informations réellement différentes. (2 pts)

2. Expliquez le problème posé par les mots-clés du document 1 quand on cherche « toutes les informations sur la dénutrition de la personne âgée ». (2 pts)

3. Regroupez les dix mots-clés d'exemple en trois mots-clés retenus. Indiquez lequel est conservé et lesquels deviennent des renvois. (4 pts)

4. Après ce travail, la liste fermée compte 24 mots-clés. Calculez le pourcentage de la liste de départ que cela représente, puis proposez deux règles pour éviter de nouveaux doublons. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans une cuisine centrale (fictive) qui livre des écoles, un foyer de personnes handicapées et un service de portage de repas à domicile. Cette semaine, quatre informations sont arrivées.

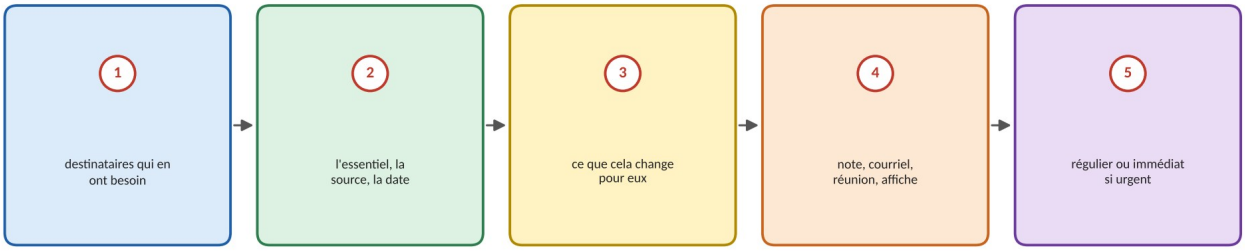


Figure 19.6 – Document 1 – La diffusion ciblée d'une information (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine (exemples fictifs)

- **I1.** Rappel de lots d'un fromage livré la semaine dernière, pour présence possible de *Listeria*.
- **I2.** Un nouvel avis sur les apports en sel chez l'enfant.
- **I3.** Un appel à projets du département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées par le repas.
- **I4.** Un article de presse sur une « nouvelle tendance » de petits-déjeuners protéinés.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Construisez une matrice de diffusion : pour chaque information, indiquez qui, pourquoi, comment et quand. (7 pts)
3. Une information n'est diffusée à personne : laquelle, et pourquoi la garder quand même dans la base ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé la note de veille mensuelle d'un service de soins de suite (fictif) destinée aux soignants. La cadre la trouve « illisible ». Vous la reprenez.

Document 1 – La note du stagiaire (extrait)

« Veille du mois. J'ai lu cette semaine beaucoup d'articles très intéressants. Un article de 2019 que j'ai trouvé sur Internet dit que les compléments nutritionnels oraux sont efficaces. Il y a eu aussi des nouveautés sur la vitamine D, voir le lien. Une étude chez le rat montre que le jeûne améliore la cicatrisation, ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients. Enfin, la HAS a publié quelque chose sur la dénutrition, il faudrait le lire. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq défauts de cette note. (5 pts)
2. Repérez la phrase dangereuse et expliquez pourquoi. (2 pts)
3. Proposez un plan type de note de veille d'une page. (3 pts)
4. Réécrivez une des informations selon ce plan. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets à compléter, par exemple [date]. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un groupement hospitalier (fictif) envoie chaque mois une lettre de veille par courriel aux équipes. Au bout d'un trimestre, la direction demande un bilan.

Document 1 – Ouverture et clics (données fictives, outil d'envoi)

Mois	Courriels envoyés	Lettres ouvertes	Clics vers au moins une source
Janvier	48	31	12
Février	48	27	9
Mars	52	22	5

Document 2 – Délais entre la publication d'une information et sa diffusion (jours, 12 informations, données fictives)

2 – 5 – 1 – 14 – 3 – 30 – 7 – 4 – 2 – 21 – 6 – 3

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque mois, calculez le taux d'ouverture et le taux de clics (sur les courriels envoyés). Décrivez l'évolution. (4 pts)
2. Calculez la moyenne et la médiane des délais. Expliquez pourquoi elles sont différentes. Calculez la part des informations diffusées en 7 jours au plus. (5 pts)
3. Proposez trois hypothèses pour expliquer la baisse de lecture et une action pour chacune. (3 pts)
4. Les clics ne mesurent pas l'utilité de la veille : proposez un indicateur de résultat. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention en nutrition (fictive) emploie une diététicienne qui consacre 3 heures par semaine à la veille, 45 semaines par an. Un éditeur propose une plateforme de veille à 1 200 € par an, qui regroupe les sources et trie automatiquement. Selon l'éditeur, elle ferait gagner 1 heure par semaine. Le trésorier hésite.

Document 1 – Les données (fictives)

- Coût horaire chargé de la diététicienne : 32 €.
- Abonnements actuels : une revue professionnelle à 180 € par an et une revue scientifique à 95 € par an. Ils sont gardés dans les deux options.
- Informations utilisées dans les actions de l'association l'an dernier : 40.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel de la veille actuelle et le coût par information utilisée. (4 pts)

2. Calculez le coût annuel avec la plateforme, si le gain d'une heure par semaine est réel. Comparez. (4 pts)

3. Calculez le gain de temps minimal par semaine pour que la plateforme ne coûte pas plus cher. (3 pts)

4. Rédigez votre conseil au trésorier en cinq lignes, en citant deux points à vérifier avant d'acheter. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 19.13

1. Légendes : 1 Référence ; 2 Mots-clés ; 3 Résumé ; 4 Intérêt ; 5 Usage.
2. Un favori ne contient **ni résumé ni raison** de l'avoir gardé : il faut tout relire. Il n'a **pas de mots-clés** communs : on ne le retrouve pas par sujet. Le lien peut **disparaître** ou changer, et il n'y a pas de date de consultation. Enfin, il n'est pas **partagé** avec l'équipe.
3. Exemple de fiche. **Référence** : Haute Autorité de santé, recommandation de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, [date de publication], [lien], consultée le [date]. **Mots-clés** : dénutrition ; personne âgée ; dépistage. **Résumé** : critères de diagnostic de la dénutrition et de sa sévérité chez la personne âgée, avec au moins un critère lié à la personne (phénotypique) et un critère lié à la cause (étiologique). **Intérêt** : nos patients ont plus de 70 ans et sortent d'une fracture : population à risque ; vérifier que notre protocole d'entrée utilise ces critères. **Usage** : présenté en réunion de service le [date] ; protocole d'entrée à mettre à jour.

Corrigé – Exercice 19.14

1. Doublons : 63 / 420 = **15 %**. Informations différentes : 420 – 63 = **357**.
2. Les mêmes idées sont notées avec des **mots différents** (synonymes, abréviations, pluriels). Une recherche sur « dénutrition » ne trouve pas les fiches notées « malnutrition » ou « perte de poids involontaire » : on oublie des informations, c'est du **silence**.
3. Exemple : **dénutrition** (retenu) ← dénutri, malnutrition, perte de poids involontaire ; **personne âgée** (retenu) ← PA, seniors, sujet âgé ; **EHPAD** (retenu) ← maison de retraite. On peut discuter : « malnutrition » englobe aussi l'excès ; la règle est de **décider une fois** et de noter le choix dans le thésaurus.
4. 24 / 118 = **20,3 %** des mots-clés de départ. Règles : ne choisir les mots-clés **que dans la liste fermée** (menu déroulant) ; un seul **responsable** ajoute un mot-clé nouveau ; **rechercher** dans le tableur (titre ou DOI) avant d'ajouter une ligne ; faire un tri des doublons chaque trimestre.

Corrigé – Exercice 19.15

1. Légendes : 1 Qui ; 2 Quoi ; 3 Pourquoi ; 4 Comment ; 5 Quand.
2. Matrice :

Information	Qui	Pourquoi	Comment	Quand
I1 Rappel de lots	Chef de cuisine, responsable qualité, magasinier, sites livrés	Retirer le produit, protéger les convives (dont des personnes fragiles)	Appel téléphonique puis courriel avec les numéros de lots	**Immédiatement**
I2 Avis sel enfant	Chef de cuisine, gestionnaire des menus scolaires	Revoir les recettes et le salage des plats	Note de veille, puis réunion menus	Note mensuelle
I3 Appel à projets	Direction, responsable du portage	Financer une action repas partagé	Courriel avec la date limite	**Rapidement**, selon la date limite
I4 Tendance presse	Personne (ou un mot en réunion si des familles posent la question)	Information non vérifiée, sans lien direct avec nos publics	–	–

3. **I4** : non diffusée car ce n'est pas une source fiable et elle ne change rien aujourd'hui. On la garde dans la base (axe sociétal) pour **repérer une tendance** si elle revient, et pour préparer une réponse si des familles ou des convives en parlent.

Corrigé – Exercice 19.16

1. Défauts : **pas de date** ni de destinataires ; **aucune référence** précise (« un article trouvé sur Internet », « voir le lien ») ; information **ancienne** (2019) présentée comme une nouveauté ; termes **vagues** (« efficaces », « des nouveautés », « quelque chose ») ; aucun **« ce que cela change pour nous »** ; le stagiaire parle de lui (« j'ai lu ») au lieu d'aller à l'essentiel ; la HAS est citée sans avoir été **lue**.
2. « Ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients » : on ne transpose **pas** un résultat chez le **rat** à des patients, encore moins le **jeûne** chez des patients de soins de suite, souvent à risque de dénutrition. C'est dangereux et contraire aux recommandations.
3. Plan : **titre** et numéro ; **date** et destinataires ; trois à cinq **informations**, chacune avec un titre court, deux lignes de contenu, la **source** datée, « **ce que cela change pour nous** » ; une rubrique « **à venir** » ; le **contact** de la personne qui fait la veille.
4. Exemple : **Dénutrition : la HAS publie ses critères de diagnostic chez la personne âgée.** La recommandation précise les critères pour poser le diagnostic et évaluer la sévérité de la dénutrition chez les personnes de 70 ans et plus. Source : HAS, [titre exact], [date], [lien]. Ce que cela change pour nous : vérifier que la fiche d'entrée du service contient ces critères ; présentation par la diététicienne à la réunion du [date].

Corrigé – Exercice 19.17

1. Janvier : 31 / 48 = **64,6 %** d'ouverture et 12 / 48 = **25,0 %** de clics. Février : 27 / 48 = **56,3 %** et 9 / 48 = **18,8 %**. Mars : 22 / 52 = **42,3 %** et 5 / 52 = **9,6 %**. Les deux taux **baissent** chaque mois : l'ouverture perd 22 points en deux mois, les clics sont divisés par plus de deux.
2. Somme : 98 jours. Moyenne : 98 / 12 ≈ **8,2 jours**. Valeurs rangées : 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 14 – 21 – 30 ; médiane : (4 + 5) / 2 = **4,5 jours**. La moyenne est tirée vers le haut par **trois délais longs** (14, 21 et 30 jours) ; la médiane n'est pas sensible à ces valeurs extrêmes. Diffusées en 7 jours au plus : 9 / 12 = **75 %**.
3. Exemples : lettre **trop longue** → la réduire à une page et à trois informations ; **objet du courriel** peu clair → un objet qui annonce l'information principale ; informations **pas assez ciblées** → des rubriques par service ou des envois ciblés ; **lassitude** → présenter la lettre en cinq minutes en réunion de service. On peut aussi demander l'avis des destinataires.
4. Exemple : **nombre d'informations utilisées** (protocole modifié, document patient mis à jour, action menée) par trimestre, relevé auprès des cadres ; ou part des destinataires qui déclarent avoir utilisé au moins une information.

Corrigé – Exercice 19.18

1. Temps : 3 × 45 = **135 h** par an. Coût : 135 × 32 = 4 320 € ; plus 180 + 95 = 275 € d'abonnements : **4 595 € par an**. Par information utilisée : 4 595 / 40 ≈ **114,88 €**.
2. Temps : 2 × 45 = 90 h, soit 90 × 32 = 2 880 € ; plus 275 € et 1 200 € : **4 355 € par an**. La plateforme coûterait **240 € de moins** (soit 108,88 € par information utilisée, si le nombre reste 40).
3. La plateforme coûte 1 200 € ; il faut gagner au moins 1 200 / 32 = 37,5 h par an, soit 37,5 / 45 ≈ **0,83 h**, environ **50 minutes par semaine**.
4. Exemple : « La plateforme ne serait rentable que si elle fait gagner au moins 50 minutes par semaine ; l'éditeur annonce une heure, la marge est donc faible. Je conseille de demander un **essai gratuit** d'un ou deux mois et de mesurer le temps réel. Il faut vérifier que la plateforme couvre **nos sources** (ANSES, HAS, Santé publique France, revues) et comment elle **trie** (un tri automatique peut écarter des informations utiles). Le temps gagné pourrait servir à mieux diffuser. » Ces calculs reposent sur des données fictives et sur l'annonce de l'éditeur.

Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les critères de fiabilité d'une source et les appliquer.
- Noter et comparer plusieurs sites avec une grille.
- Pratiquer la lecture latérale et la méthode SIFT.
- Repérer un graphique trompeur et calculer l'effet réel.
- Vérifier des références proposées par un outil d'intelligence artificielle.
- Repérer un contenu sponsorisé et connaître les obligations des influenceurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six critères de fiabilité : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **sources** citées et vérifiables ; **méthode** décrite ; **intérêts** déclarés ; **prudence** des conclusions.
- **Lecture latérale** : au lieu de lire longtemps un site inconnu, on ouvre d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière et **ce qu'en disent** des sources fiables.
- **SIFT** (Caulfield, 2019) : *Stop* (s'arrêter), *Investigate the source* (enquêter sur la source), *Find better coverage* (chercher une meilleure source), *Trace claims* (remonter à l'origine de l'affirmation).
- Un outil d'IA générative peut produire des **références qui n'existent pas** : chaque référence se vérifie (DOI, PubMed, site de la revue).
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 : un contenu d'**influence commerciale** doit porter la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire, lisible et identifiable.

Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier pour des parents dans un centre social (fictif), une maman montre une page web : « C'est écrit par un docteur, c'est donc vrai ? »

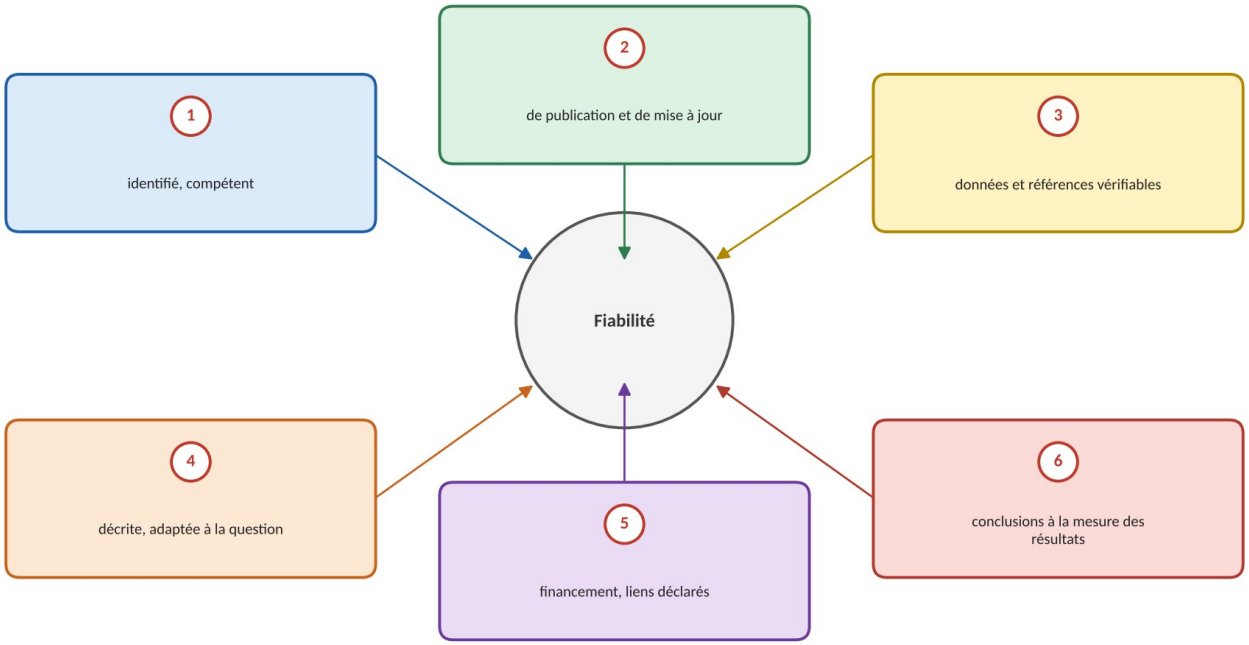


Figure 19.7 – Document 1 – Juger la fiabilité d'une source (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque critère, formulez une question simple que la maman peut se poser devant une page web. (3 pts)
3. Répondez à la maman en trois phrases : le titre de « docteur » suffit-il ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le critère « prudence » est souvent le plus facile à repérer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une veille sur l'alimentation pendant la grossesse, une sage-femme d'une PMI (fictive) a repéré quatre sites. Vous les notez avec la grille des six critères : 0 (absent), 1 (partiel), 2 (satisfaisant), soit une note sur 12.

Document 1 – Description des quatre sites (exemples fictifs)

- **Site A.** Site d'une agence publique de santé. Pages signées par l'agence, mises à jour en 2025, références aux avis scientifiques, méthode d'expertise décrite, déclarations d'intérêts des experts publiées. Ton prudent, mais quelques pages anciennes non datées.
- **Site B.** Blog « Maman naturelle ». Auteur sous pseudonyme, pas de date, aucune source, vend une « cure détox grossesse », annonce : « Zéro nausée garanti en 3 jours ! »
- **Site C.** Site d'une clinique privée. Article signé par un gynécologue, daté de 2017, deux références citées, sans méthode ; bannière publicitaire pour des compléments de la clinique ; conclusion assez prudente.
- **Site D.** Site d'une société savante de périnatalité. Recommandations datées et signées par un groupe de travail, références nombreuses, méthode décrite ; mise à jour de 2021 ; liens d'intérêts publiés ; conclusions nuancées.

À vous de jouer – Questions

1. Notez chaque site sur les six critères et calculez sa note sur 12, puis sur 20. (6 pts)

2. Classez les sites. Lesquels intégrez-vous à la veille ? (3 pts)

3. Le site C a une note moyenne : que faut-il faire de ses informations ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un adhérent d'une salle de sport (fictive) vous envoie le lien d'un site très bien présenté, « Institut européen de nutrition sportive », qui affirme : « Une étude montre que 3 g de notre extrait de racine augmentent la force de 30 %. » Le site a un logo sérieux, des photos de laboratoire et des témoignages.

Document 1 – Ce que vous trouvez en ouvrant d'autres onglets (situation fictive)

- Les mentions légales indiquent que le site appartient à une société qui vend l'extrait.
- Aucun registre officiel ne mentionne d'« Institut européen de nutrition sportive ».
- L'« étude » citée a été réalisée sur 12 personnes, sans groupe témoin, financée par la même société ; elle n'est pas publiée dans une revue relue par des pairs.
- Les sites de référence (ANSES, revues de sport) ne mentionnent pas cet extrait.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre lire un site « verticalement » et le lire « latéralement ». (2 pts)
2. Appliquez les quatre étapes SIFT à ce site, en vous servant du document 1. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi un site bien présenté peut tromper même une personne attentive. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'adhérent en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une publicité (fictive) pour une boisson lactée affirme : « Votre cholestérol chute ! » Elle montre un graphique en barres : la barre « avant » est presque deux fois plus haute que la barre « après ».

Document 1 – Les données du graphique (fictives)

	Cholestérol total moyen (mmol/L)
Avant (début de l'étude)	5,32
Après 6 semaines de boisson	5,18

L'axe vertical commence à 5,0 mmol/L. L'étude porte sur 20 volontaires, sans groupe témoin, financée par le fabricant.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la baisse réelle en mmol/L et en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la hauteur visible de chaque barre au-dessus de 5,0 et la baisse « visuelle » en pourcentage. Expliquez l'effet de l'axe tronqué. (4 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Proposez deux corrections pour un graphique honnête et reformulez le slogan de façon exacte. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante a demandé à un outil d'intelligence artificielle générative « cinq références scientifiques sur l'effet des fibres sur la satiété ». Elle les a copiées dans son dossier. Votre tutrice vous demande de les vérifier. Les références et les résultats de vérification ci-dessous sont **fictifs**, construits pour l'exercice.

Document 1 – Résultats de votre vérification (situation fictive)

Référence	Recherche du DOI	Recherche dans PubMed	Site de la revue
R1	DOI valide, renvoie vers l'article	Trouvée, titre et auteurs identiques	Article présent
R2	DOI renvoie vers un autre article (sur le sommeil)	Titre introuvable	Volume et pages inexistants
R3	Pas de DOI	Titre proche trouvé, mais auteurs et année différents	Article présent avec d'autres auteurs
R4	DOI « introuvable »	Aucun résultat	La revue n'existe pas
R5	DOI valide	Trouvée	Article présent, mais il porte sur les fibres et le transit, pas sur la satiété

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque référence : utilisable, à corriger, à rejeter ou hors sujet. Justifiez. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi un outil d'IA générative peut produire des références qui ont l'air vraies mais n'existent pas. (3 pts)
3. Décrivez une méthode de vérification en quatre étapes. (4 pts)
4. Indiquez comment l'étudiante doit mentionner l'usage de l'IA dans son dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « Réseaux sociaux et alimentation » pour des lycéens dans un point information jeunesse (fictif). Vous préparez trois exemples fictifs de publications.

Document 1 – Trois publications (exemples fictifs)

- **P1.** Une créatrice de contenu montre son petit-déjeuner avec une poudre protéinée d'une marque, avec un code promo. Aucune mention de partenariat. Texte : « Mon secret pour garder la ligne ! »
- **P2.** Un influenceur « bien-être » écrit : « J'ai arrêté mon traitement contre l'hypertension, je me soigne seulement avec un jus de céleri chaque matin. Faites comme moi ! » Mention « Collaboration commerciale » avec une marque de jus.
- **P3.** Une diététicienne publie une vidéo sur la lecture des étiquettes, sans produit mis en avant, avec ses sources (ANSES, Santé publique France).

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque publication, dites s'il s'agit d'influence commerciale et si elle respecte la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi P2 est grave, même avec la mention « Collaboration commerciale ». (3 pts)
3. Proposez trois questions que les lycéens peuvent se poser devant une publication sur l'alimentation. (3 pts)
4. Proposez deux actions pour signaler ou contrer ces contenus, et une façon d'intégrer ce sujet à votre veille sociétale. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 19.19

1. Légendes : 1 Auteur ; 2 Date ; 3 Sources citées ; 4 Méthode ; 5 Intérêts ; 6 Prudence.
2. Auteur : « Qui a écrit ? Est-il compétent sur ce sujet ? » Date : « Quand est-ce écrit ou mis à jour ? » Sources : « Sur quoi s'appuie-t-il ? Puis-je vérifier ? » Méthode : « Comment sait-il cela : étude, expérience personnelle ? » Intérêts : « Vend-il quelque chose ? Qui paie le site ? » Prudence : « Promet-il des résultats garantis ou miraculeux ? »
3. « Un titre de docteur ne suffit pas. Il faut savoir s'il est compétent en nutrition de l'enfant, sur quoi il s'appuie et s'il vend un produit. Une information est fiable quand d'autres sources sérieuses (agences de santé, pédiatres) disent la même chose. »
4. Les promesses excessives se **voient tout de suite** : « garanti », « miracle », « en 3 jours », « ce que les médecins vous cachent ». La science parle de **probabilités** et de **limites** ; un ton absolu est un signal d'alerte, même avant de chercher l'auteur ou les sources.

Corrigé – Exercice 19.20

1. Notes proposées (auteur, date, sources, méthode, intérêts, prudence). A : 2, 2, 2, 2, 2, 1 → **11 / 12**, soit 18,3 / 20 (on retire un point en « prudence » ou en « date » pour les pages non datées ; un autre choix est acceptable s'il est justifié). B : 0, 0, 1, 0, 0, 0 → **1 / 12**, soit 1,7 / 20 (un point pour une source au mieux partielle ; 0 / 12 est aussi acceptable). C : 2, 1, 1, 1, 0, 1 → **6 / 12**, soit 10 / 20. D : 1, 2, 2, 1, 2, 2 → **10 / 12**, soit 16,7 / 20 (auteurs collectifs ; méthode décrite mais à vérifier ; une note de 11 est acceptable).
2. Classement : **A, D, C, B**. On intègre A et D à la veille (lettre d'information ou flux RSS). B est exclu. C n'est pas suivi en continu.
3. Les informations du site C ne sont pas fausses pour autant, mais l'article est **ancien** (2017) et la clinique a un **intérêt** (compléments vendus). On **vérifie** chaque information auprès de A ou D avant de l'utiliser ; si elle n'y figure pas, on ne la diffuse pas.

Corrigé – Exercice 19.21

1. Lire **verticalement**, c'est rester sur la page et juger d'après son aspect, ses photos, son ton. Lire **latéralement**, c'est quitter vite la page et ouvrir d'autres onglets pour vérifier **qui** publie et **ce qu'en disent** d'autres sources fiables.
2. **Stop** : ne pas partager ni acheter tout de suite ; se demander si l'on connaît ce site. **Investigate the source** : les mentions légales montrent que l'« institut » est une **société qui vend l'extrait**, et il n'existe dans aucun registre. **Find better coverage** : l'ANSES et les revues de sport n'en parlent pas ; aucune source indépendante ne confirme. **Trace claims** : l'« étude » d'origine porte sur **12 personnes**, sans **groupe témoin**, **financée** par le vendeur et **non publiée** : on ne peut rien conclure sur le chiffre de 30 %.
3. Un site moderne, un logo, un nom qui sonne officiel (« institut », « européen »), des photos de laboratoire et des témoignages donnent une impression de sérieux. Ces éléments coûtent peu et **ne prouvent rien** sur la qualité de l'information.
4. « J'ai vérifié : ce site appartient à l'entreprise qui vend l'extrait, et son étude porte sur 12 personnes sans comparaison. On ne peut pas dire que ce produit augmente la force. Pour progresser, l'entraînement, l'alimentation et le sommeil restent les bases ; parlons-en si vous voulez. »

Corrigé – Exercice 19.22

1. Baisse réelle : 5,32 − 5,18 = **0,14 mmol/L**, soit 0,14 / 5,32 = **2,6 %**.
2. Hauteurs visibles : 5,32 − 5,0 = **0,32** et 5,18 − 5,0 = **0,18**. Baisse visuelle : (0,32 − 0,18) / 0,32 = **43,8 %**. La barre « avant » paraît 0,32 / 0,18 ≈ **1,8 fois** plus haute. En coupant l'axe à 5,0 au lieu de 0, on **grossit**

visuellement une baisse très faible.

3. Limites : **20 volontaires** seulement ; **pas de groupe témoin** (les volontaires ont pu changer d'autres habitudes, ou l'effet de « régression vers la moyenne » peut jouer) ; **financement** par le fabricant ; durée courte (6 semaines) ; aucune indication de variabilité (écart-type, intervalle) ni de test ; pas de lien démontré avec la santé cardiovasculaire.
4. Corrections : faire partir l'axe de **0** (ou signaler clairement la coupure) ; donner la **valeur exacte** et son incertitude, l'effectif et l'absence de groupe témoin. Slogan exact : « Chez 20 volontaires, sans groupe de comparaison, le cholestérol total moyen est passé de 5,32 à 5,18 mmol/L en 6 semaines (– 2,6 %). » Ce slogan honnête n'a plus d'effet publicitaire : c'est bien le signe que le premier exagérait.

Corrigé – Exercice 19.23

1. R1 : **utilisable** (DOI, PubMed et revue concordent ; il faut tout de même lire l'article). R2 : **à rejeter** (le DOI renvoie vers un autre article et le volume n'existe pas : référence inventée). R3 : **à corriger** ou à rejeter (un article proche existe mais les auteurs et l'année sont faux ; on cite le vrai article seulement après l'avoir lu et vérifié qu'il traite bien de la question). R4 : **à rejeter** (revue inexistante). R5 : **hors sujet** (l'article existe mais ne répond pas à la question ; le citer pour la satiété serait une erreur).
2. Un outil d'IA générative produit un texte **vraisemblable** en prédisant les mots les plus probables. Il connaît la **forme** d'une référence (auteurs, titre, revue, année, DOI) et peut l'assembler sans vérifier qu'elle existe. Il peut aussi mélanger des éléments de plusieurs vraies références.
3. Méthode : 1) chercher le **DOI** sur doi.org ; 2) chercher le **titre exact** dans PubMed ou Google Scholar ; 3) vérifier que la **revue**, l'année, le volume et les auteurs correspondent ; 4) **lire** au moins le résumé pour vérifier que l'article dit bien ce qu'on lui fait dire. Une référence que l'on n'a pas lue ne se cite pas.
4. Elle respecte les règles de son établissement ; en général, elle indique **quel outil** a été utilisé, **pour quoi** (par exemple, une première liste de pistes), et précise que toutes les références ont été **vérifiées et lues**. L'IA n'est ni une source ni un auteur.

Corrigé – Exercice 19.24

1. P1 : **influence commerciale** (produit d'une marque, code promo) **sans mention** : non conforme ; il faudrait « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire et visible. P2 : influence commerciale **avec** mention, mais le contenu incite à **arrêter un traitement** : la loi interdit la promotion de l'**abstention thérapeutique** ; contenu non conforme. P3 : **pas** d'influence commerciale (aucun produit, aucun partenariat) : information de prévention, sources citées.
2. P2 pousse des personnes hypertendues à **arrêter un traitement** : risque d'accident vasculaire ou cardiaque. Le jus de céleri ne remplace pas un médicament ; l'affirmation est sans preuve. La mention de partenariat ne rend pas le message acceptable : elle dit seulement qu'il est payé.
3. Exemples : « Cette personne gagne-t-elle de l'argent si j'achète ? » ; « Sur quoi s'appuie-t-elle : une étude, une source officielle, son expérience ? » ; « Est-ce que ça promet un résultat rapide ou garanti ? » ; « Est-ce qu'un professionnel de santé ou une agence dit la même chose ? »
4. Actions : **signaler** la publication à la plateforme ; signaler une pratique commerciale trompeuse à la DGCCRF (plateforme SignalConso) ; produire un **contenu de réponse** simple et sourcé ; en parler à l'infirmière scolaire si des jeunes suivent ces conseils. Veille : suivre quelques **mots-dièses** et comptes populaires auprès des jeunes, une fois par mois, et noter les tendances dans la base (axe sociétal).

Partie 5 – La publication scientifique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication.
- Repérer les signaux d'une revue prédatrice.
- Utiliser un DOI pour retrouver et citer un article.
- Distinguer erratum et rétractation, et en tirer les conséquences pour la veille.
- Rechercher les liens d'intérêts d'un auteur ou d'un intervenant.
- Lire avec prudence un preprint.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Circuit : **soumission**, **relecture par les pairs** (experts indépendants), **révision**, **publication** (numéro, DOI, date), **après publication** (commentaires, erratum, rétractation).
- Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique et permanent** d'un document ; il commence par « 10. ».
- Un **erratum** corrige une erreur sans remettre en cause les conclusions ; une **rétractation** retire l'article : on ne peut plus s'appuyer sur ses résultats.
- Une **revue prédatrice** fait payer la publication sans vraie relecture. Signaux : délai très court, sollicitation flatteuse, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation.
- Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne **avant** la relecture par les pairs : c'est une information provisoire.
- La base **Transparence Santé** publie les liens (conventions, avantages, rémunérations) entre les entreprises du secteur de la santé et les professionnels.

Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne hospitalière (fictive) a participé à une étude et l'a soumise à une revue. Elle vous montre les dates du suivi de son article.

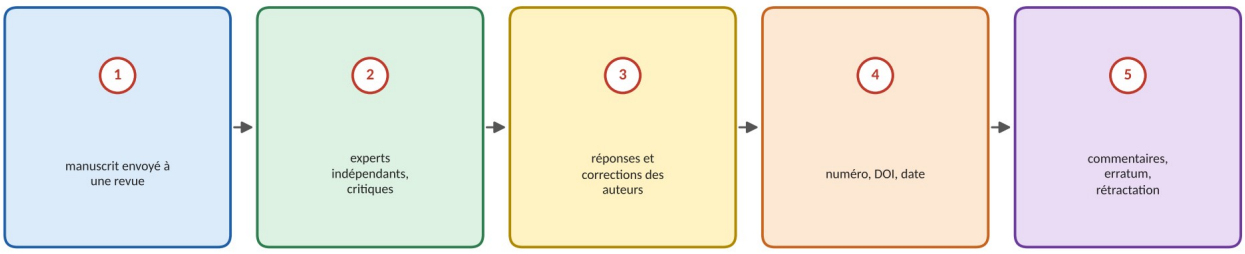


Figure 19.8 – Document 1 – Le circuit d'un article scientifique (schéma à légender)

Document 2 – Les dates du suivi de l'article (exemple fictif)

Événement	Date
Soumission	3 mars 2025
Retour des relecteurs (demande de corrections)	12 mai 2025
Envoi de la version révisée	20 juin 2025
Acceptation	28 juillet 2025
Publication en ligne	15 septembre 2025

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Calculez la durée de chaque étape en jours, puis la durée totale entre soumission et publication, en jours et en semaines. (4 pts)
3. Expliquez le rôle des relecteurs et pourquoi ils doivent être indépendants des auteurs. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après avoir présenté un poster à un congrès, un diététicien libéral reçoit le courriel suivant. Il vous demande s'il doit accepter.

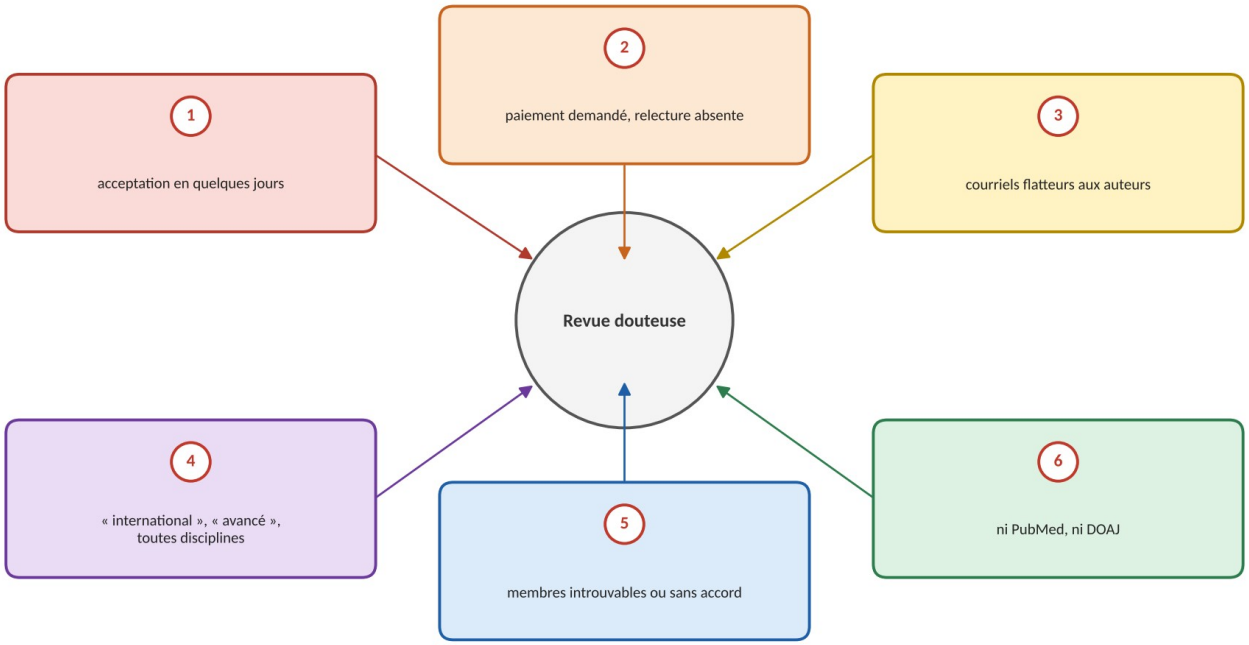


Figure 19.9 – Document 1 – Les signaux d'une revue prédatrice (schéma à légender)

Document 2 – Le courriel reçu (exemple fictif)

« Dear Eminent Researcher, we have read with great interest your outstanding work. The *International Advanced Journal of Medicine, Nutrition, Engineering and Social Sciences* invites you to submit your article. Peer review in 4 days. Publication fee: only 1 450 USD. Our editorial board includes 60 world-famous professors. Submit before Friday to get a 20 % discount! »

Vérifications faites par le diététicien (situation fictive) : la revue n'est indexée ni dans PubMed ni dans le DOAJ ; deux membres du comité éditorial déclarent sur leur site ne pas avoir accepté d'en faire partie.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez dans le document 2 et dans les vérifications au moins cinq signaux d'une revue prédatrice. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi publier dans une telle revue nuit à l'auteur et au lecteur. (2 pts)
4. Citez deux outils pour vérifier une revue avant de soumettre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.27 – Le DOI (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la base de veille d'un service de nutrition (fictif), trois fiches posent problème. Vous les examinez.

Document 1 – Trois fiches de la base (exemples fictifs)

- **F1.** Référence : « article sur le sel, revue anglaise, 2022 », lien vers une page qui affiche « Erreur 404 ».
- **F2.** Référence complète avec le DOI « 10.1000/exemple.2023.0456 ». Le lien de la revue a changé, mais le DOI fonctionne.
- **F3.** Deux fiches portent le même DOI mais des titres légèrement différents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un DOI et ses deux qualités principales. (3 pts)
2. Indiquez comment retrouver un article à partir de son DOI. (2 pts)
3. Pour chaque fiche, dites ce qui se passe et ce qu'il faut faire. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi le champ « DOI » doit être obligatoire dans la base, quand il existe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En faisant la veille d'un réseau de diététiciens (fictif), vous trouvez deux notices sur des articles déjà présents dans la base.

Document 1 – Deux notices (exemples fictifs)

- **N1.** « Erratum. Dans le tableau 2, l'unité de la colonne “vitamine D” est µg et non mg. Les résultats et les conclusions ne sont pas modifiés. »
- **N2.** « Rétractation. Cet article est retiré à la demande de la revue. Une enquête a montré que des données de 120 participants avaient été dupliquées. Les résultats ne sont pas fiables. »

L'article N2 est cité dans 4 documents produits par le réseau : une fiche patient, une note de veille, une présentation de formation et un poster.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre un erratum et une rétractation. (3 pts)
2. Pour N1, que faut-il faire dans la base ? (2 pts)
3. Pour N2, listez les actions à mener, document par document. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi un article rétracté continue souvent à être cité et comment la veille peut l'éviter. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) invite un médecin à une soirée de formation sur les compléments alimentaires. Avant l'invitation, la présidente consulte la base Transparence Santé. Elle vous transmet le résultat.

Document 1 – Avantages et rémunérations déclarés sur 12 mois (données fictives)

Entreprise	Nature	Nombre	Montant unitaire (€)
X (compléments alimentaires)	Repas	4	45
X (compléments alimentaires)	Hébergement lors d'un congrès	1	380
Y (compléments alimentaires)	Rémunération de conférences	2	600
Z (laboratoire pharmaceutique)	Repas	3	38

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le montant total par entreprise, le montant total, et la part de l'entreprise Y. (4 pts)
2. Expliquez ce qu'est un lien d'intérêts et pourquoi il ne signifie pas forcément que l'intervenant ment. (3 pts)
3. Proposez une conduite à tenir pour la soirée de formation. (4 pts)
4. Expliquez où trouver les déclarations d'intérêts des experts d'une agence comme l'ANSES ou la HAS. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans un service de santé au travail (fictif). Un salarié vous montre un article de presse en ligne (exemple fictif) : « Une étude prouve que deux cafés par jour divisent par deux le risque de diabète ! »

Document 1 – Ce que dit l'étude d'origine (exemple fictif)

- Manuscrit déposé sur un serveur de preprints il y a 10 jours, **non relu par des pairs**.
- Étude transversale sur 1 800 salariés ; un questionnaire sur la consommation de café et sur un diabète déjà diagnostiqué.
- Résultat : la part de personnes diabétiques est plus faible chez les buveurs de 2 cafés par jour ; l'analyse ne tient pas compte de l'âge ni de l'activité physique.
- Les auteurs écrivent : « Ces résultats préliminaires devront être confirmés. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un preprint, son intérêt et sa limite principale. (3 pts)

2. Relevez quatre écarts entre le titre de presse et l'étude d'origine. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi une étude transversale ne peut pas montrer que le café « divise le risque ». Proposez un facteur de confusion possible. (4 pts)

4. Rédigez votre réponse au salarié (cinq lignes) et dites ce que vous faites dans votre base de veille. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 19.25

1. Légendes : 1 Soumission ; 2 Relecture par les pairs ; 3 Révision ; 4 Publication ; 5 Après publication.
2. Relecture : du 3 mars au 12 mai, **70 jours**. Révision par les auteurs : du 12 mai au 20 juin, **39 jours**. Nouvel examen jusqu'à l'acceptation : **38 jours**. De l'acceptation à la publication : **49 jours**. Total : **196 jours**, soit **28 semaines** (environ six mois et demi).
3. Les relecteurs sont des **experts** du sujet. Ils vérifient la **méthode**, la cohérence des **résultats** et la **prudence** des conclusions ; ils demandent des corrections ou proposent le refus. Ils doivent être **indépendants** des auteurs (ni collègues proches, ni concurrents directs, ni financés par le même industriel) pour juger sans complaisance ni hostilité.

Corrigé – Exercice 19.26

1. Légendes : 1 Délai très court ; 2 Frais sans relecture ; 3 Sollicitation ; 4 Titre fourre-tout ; 5 Comité douteux ; 6 Indexation absente.
2. Signaux : **sollicitation** flatteuse et impersonnelle (« Dear Eminent Researcher », « outstanding work ») ; **titre fourre-tout** (médecine, nutrition, ingénierie et sciences sociales) avec « International Advanced » ; relecture en **4 jours** ; **frais** mis en avant (1 450 USD) avec une **remise** et une **pression** sur la date ; **comité** « de 60 professeurs célèbres » dont deux n'ont pas accepté ; **absence d'indexation** dans PubMed et le DOAJ.
3. Pour l'**auteur** : son travail perd sa crédibilité, il paie sans relecture utile, l'article peut disparaître du site et ne pourra plus être soumis ailleurs. Pour le **lecteur** : il lit un article non vérifié, qui peut contenir des erreurs, présenté comme « publié ».
4. Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) pour les revues en libre accès ; la démarche **Think. Check. Submit.** (liste de questions sur la revue) ; vérifier l'**indexation** dans PubMed ou le catalogue NLM ; demander l'avis d'un documentaliste ou d'un collègue qui publie.

Corrigé – Exercice 19.27

1. Un **DOI** est un identifiant numérique attribué à un document (article, rapport). Il est **unique** (un seul document par DOI) et **permanent** (il reste valable même si le site de l'éditeur change d'adresse).
2. On tape « https://doi.org/ » suivi du DOI dans un navigateur ; on peut aussi coller le DOI dans PubMed ou Google Scholar.
3. F1 : référence **incomplète** et lien **mort** ; il faut retrouver l'article (titre, revue, sel, 2022) dans PubMed, noter la référence complète et le DOI, sinon supprimer la fiche. F2 : **correct** ; on remplace le lien de la revue par le lien « doi.org » pour éviter le problème à l'avenir. F3 : **doublon** ; on garde une seule fiche, avec le titre exact, et l'on fusionne les mots-clés et les usages.
4. Le DOI permet de **retrouver** l'article à coup sûr, de repérer les **doublons**, de produire facilement une **bibliographie**, et de vérifier s'il y a eu un **erratum** ou une **rétractation** (les notices sont liées à l'article).

Corrigé – Exercice 19.28

1. Un **erratum** corrige une **erreur ponctuelle** (faute, unité, chiffre d'un tableau) sans changer les conclusions : l'article reste utilisable. Une **rétractation retire** l'article (fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat) : ses résultats ne doivent plus être utilisés.
2. N1 : ajouter l'erratum à la fiche (référence, date), corriger l'unité si la valeur a été reprise dans un document, garder l'article.
3. N2 : dans la base, marquer la fiche **« rétracté »** avec la date et la notice, sans la supprimer (pour garder la trace). **Fiche patient** : la retirer ou la corriger en priorité, car elle est diffusée au public. **Note de veille** :

publier un **rectificatif** dans la note suivante. **Présentation de formation** : la mettre à jour avant la prochaine session et prévenir les personnes formées si le point était important. **Poster** : signaler la rétractation aux auteurs du poster ; ne plus le présenter tel quel.

4. Les lecteurs ont **téléchargé** l'article avant la rétractation ; d'autres documents l'ont **repris** ; la notice de rétraction n'est pas toujours visible. Exemple réel connu : l'article de Wakefield sur la vaccination ROR, publié dans *The Lancet* en 1998 et rétracté en 2010, est encore cité. La veille peut l'éviter en **vérifiant le statut** des articles importants avant chaque diffusion (notice sur la page de la revue, mention dans PubMed) et en faisant un contrôle annuel de la base.

Corrigé – Exercice 19.29

1. X : 4 × 45 + 380 = 180 + 380 = **560 €**. Y : 2 × 600 = **1 200 €**. Z : 3 × 38 = **114 €**. Total : 560 + 1 200 + 114 = **1 874 €**. Part de Y : 1 200 / 1 874 = **64,0 %**.
2. Un **lien d'intérêts** est une relation (financière ou autre) avec une entreprise ou un organisme qui a un intérêt dans le sujet. Il ne prouve pas que l'intervenant ment, mais il peut **influencer**, même sans le vouloir, son choix des études et sa façon de présenter les résultats. Le **conflit d'intérêts** apparaît quand ce lien porte sur le sujet traité. C'est pourquoi on le **déclare**.
3. Exemples : demander à l'intervenant de **déclarer ses liens** en début de soirée (diapositive) ; lui demander de s'appuyer sur des **sources indépendantes** (ANSES, EFSA, HAS) ; prévoir une **seconde intervention** ou un temps de débat avec un intervenant sans lien ; ou choisir un autre intervenant pour ce sujet précis, ce qui est le plus simple.
4. Les experts des agences remplissent une **déclaration publique d'intérêts** (DPI), consultable sur le site public des déclarations d'intérêts des acteurs de santé ou sur le site de l'agence. Les avis de l'ANSES et de la HAS précisent aussi comment les liens ont été analysés.

Corrigé – Exercice 19.30

1. Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne par les auteurs **avant** la relecture par les pairs. Intérêt : diffuser **vite** des résultats et recevoir des commentaires. Limite : il n'a **pas été vérifié** ; il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié.
2. Écarts : « **prouve** » alors que les auteurs parlent de résultats **préliminaires** ; « **divise par deux le risque** » alors que l'étude compare des **proportions** à un moment donné ; aucune mention du statut de **preprint** non relu ; aucune mention de l'absence de prise en compte de l'**âge** et de l'**activité physique** ; « deux cafés » présenté comme une **dose** recommandée.
3. Une étude **transversale** mesure l'exposition et la maladie **en même temps** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des personnes diabétiques ont pu **réduire** leur café sur conseil médical (causalité inverse). Facteur de confusion possible : l'**âge** (les plus âgés sont plus souvent diabétiques et peuvent boire moins de café) ou l'**activité physique**.
4. Exemple : « Cette étude n'est pas encore vérifiée par d'autres chercheurs. Elle compare des buveurs et des non-buveurs de café à un moment donné, sans tenir compte de l'âge ni de l'activité : elle ne prouve pas que le café protège. Si vous aimez le café, deux tasses sans sucre ajouté peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. Pour le diabète, ce qui compte le plus reste l'activité physique, le poids et l'alimentation dans son ensemble. » Dans la base : fiche notée « **preprint, à suivre** », avec une date de contrôle dans six mois pour voir s'il a été publié après relecture.

Partie 6 – Lire une étude selon son type

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les types d'études selon leur niveau de preuve.
- Appliquer une grille de lecture critique à un résumé.
- Calculer l'effet des perdus de vue et comparer analyse « per protocole » et en intention de traiter.
- Calculer et interpréter risque absolu, risque relatif et différence de risque dans une cohorte.
- Lire le tableau d'une méta-analyse.
- Ne pas transposer sans précaution une étude chez l'animal.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Niveaux de preuve, du plus fort au plus faible : **revue systématique** (et méta-analyse) ; **essai randomisé** ; **cohorte** ; **cas-témoins** ; **étude transversale** ; **avis d'expert**, cas isolé. Les études chez l'animal et *in vitro* sont en dehors de cette échelle humaine.
- Une **grille de lecture** examine : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- **Intention de traiter** (ITT) : on analyse tous les participants dans le groupe tiré au sort, même ceux qui ont arrêté. Cette analyse protège l'intérêt du tirage au sort.
- **Risque relatif** = risque des exposés / risque des non-exposés ; **différence de risque** = risque des exposés – risque des non-exposés. Un RR élevé peut correspondre à une petite différence absolue.
- Une étude d'**observation** montre une **association**, pas une cause.

Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un réseau de prévention de l'obésité (fictif) a rangé ses documents de veille dans un ordre qu'elle juge « au hasard ». Elle vous demande de les classer par niveau de preuve.

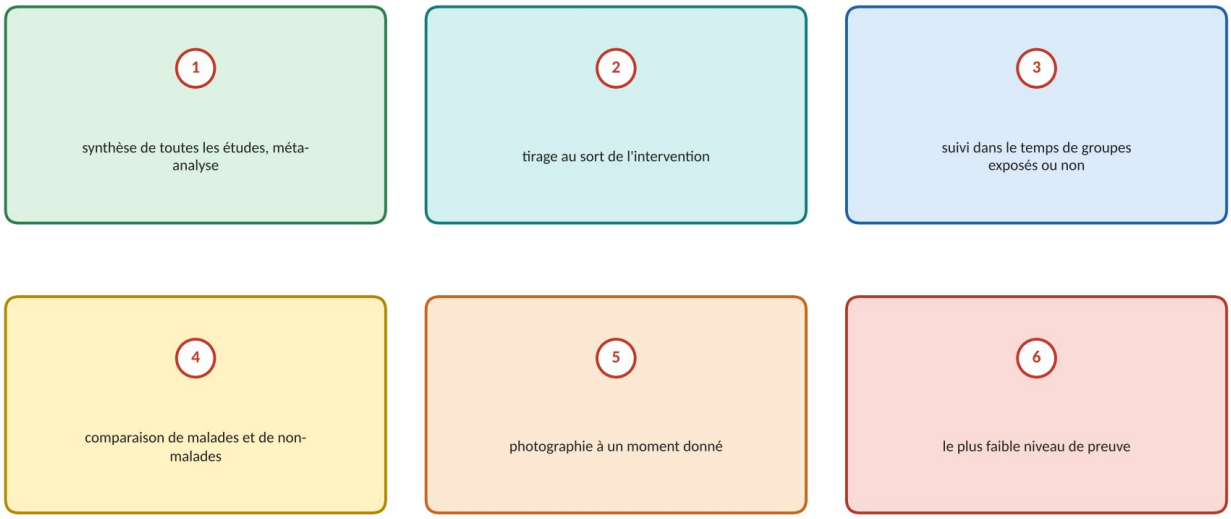


Figure 19.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve (schéma à légender)

Document 2 – Six documents (exemples fictifs)

- **A.** Une étude qui suit 15 000 adultes pendant 12 ans et relève leur alimentation et leur poids.
- **B.** Le témoignage d'un patient qui a perdu 20 kg avec une méthode.
- **C.** Un essai où 300 adultes sont tirés au sort entre deux programmes d'activité physique.
- **D.** Une enquête qui mesure en une seule fois l'alimentation et le poids de 2 000 collégiens.
- **E.** La synthèse de 18 essais sur les programmes d'éducation nutritionnelle, avec une méthode de recherche décrite.
- **F.** Une étude qui compare les habitudes passées de 200 personnes obèses et de 400 personnes non obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque document à un type d'étude et classez-les du plus fort au plus faible niveau de preuve. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'essai randomisé est plus fort que la cohorte pour montrer un effet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la veille d'un service de diabétologie (fictif), vous lisez le résumé suivant, traduit et simplifié. L'étude est **fictive**.

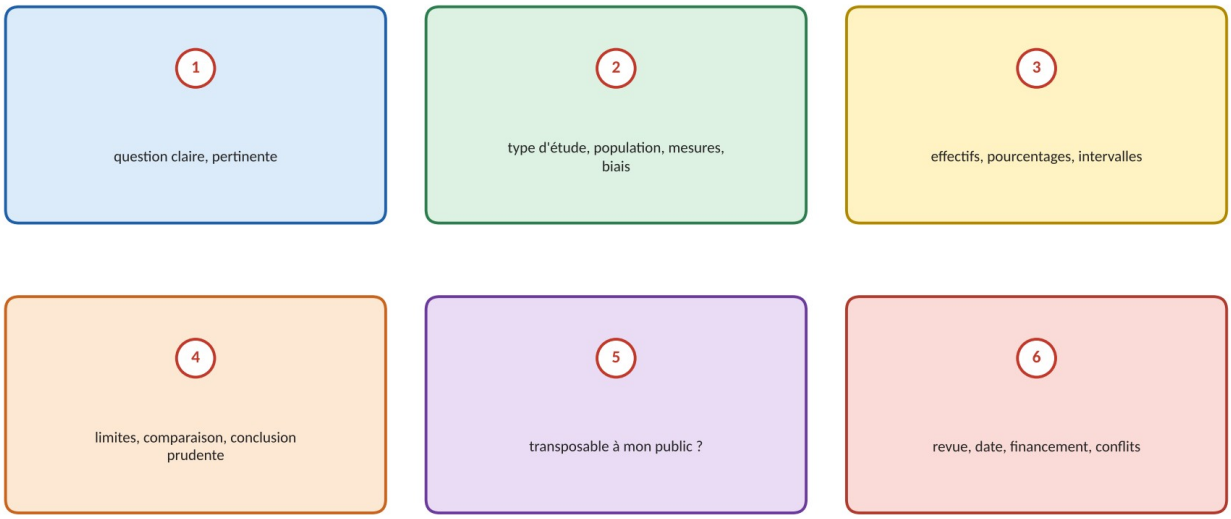


Figure 19.11 – Document 1 – La grille de lecture critique (schéma à légender)

Document 2 – Le résumé (étude fictive)

« **Objectif.** Évaluer l'effet d'un atelier de cuisine mensuel sur l'hémoglobine glyquée (HbA1c) de patients diabétiques de type 2. **Méthode.** Essai randomisé dans 4 centres ; 160 patients tirés au sort entre ateliers (n = 80) et soins habituels (n = 80) ; HbA1c mesurée au début et à 6 mois. **Résultats.** 148 patients analysés. L'HbA1c a baissé de 0,4 point de plus dans le groupe atelier (IC 95 % : 0,1 à 0,7). **Conclusion.** Les ateliers de cuisine sont une solution efficace pour tous les diabétiques. **Financement.** Fondation d'une enseigne de supermarchés. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. **2.** Appliquez chacun des six points de la grille au résumé : un point fort ou une question pour chacun. (6 pts)
3. **3.** Repérez la phrase de la conclusion qui va trop loin et réécrivez-la. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un essai randomisé **fictif** compare, chez des adultes en surpoids, un programme de coaching en ligne (groupe I) et des conseils écrits (groupe T). Le critère principal est une perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

	Groupe I (coaching)	Groupe T (conseils)
Tirés au sort	120	120
Présents à 12 mois	84	102
Perte d'au moins 5 % chez les présents	38	30

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le pourcentage de perdus de vue dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le pourcentage de réussite chez les présents (analyse « per protocole ») et la différence entre les groupes. (3 pts)
3. Calculez le pourcentage de réussite en intention de traiter, en comptant les perdus de vue comme des échecs, et la différence. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les deux analyses donnent des résultats différents, et laquelle est la plus prudente. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un magazine titre : « Les boissons sucrées augmentent de 50 % le risque de diabète ! » La source est une cohorte **fictive** de 40 000 adultes suivis 10 ans.

Document 1 – Les résultats de la cohorte (données fictives)

	Effectif	Nouveaux cas de diabète de type 2 en 10 ans
Au moins une boisson sucrée par jour	8 000	240
Moins d'une boisson sucrée par jour	32 000	640

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque dans chaque groupe, le risque relatif et la différence de risque (en points et pour 1 000 personnes). (5 pts)
2. Le titre est-il faux ? Expliquez ce qu'il cache. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une cohorte ne prouve pas que les boissons sucrées « causent » le diabète. Citez deux facteurs de confusion possibles. (4 pts)
4. Rédigez une phrase exacte et compréhensible pour une note de veille. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une méta-analyse **fictive** regroupe six cohortes sur la consommation régulière de légumineuses et le risque de maladie coronarienne. Les résultats sont présentés dans un tableau, comme dans un graphique en forêt.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Étude	Risque relatif	IC 95 %	Poids
A	0,82	0,65 à 1,03	13,7 %
B	0,95	0,80 à 1,13	24,3 %
C	0,70	0,52 à 0,94	8,3 %
D	1,05	0,85 à 1,30	16,1 %
E	0,85	0,72 à 1,00	26,9 %
F	0,78	0,60 à 1,01	10,7 %
Ensemble	**0,88**	**0,81 à 0,95**	100 %

Hétérogénéité : $I^2 = 29\ \%$.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez quelles études, prises seules, montrent une association statistiquement significative. Justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résultat d'ensemble est significatif alors que la plupart des études ne le sont pas. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les études B et E ont le poids le plus élevé et l'étude C le plus faible. (2 pts)
4. Traduisez le résultat d'ensemble en pourcentage et interprétez l'hétérogénéité. (3 pts)
5. Donnez une limite d'une méta-analyse de cohortes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez dans une pharmacie qui propose des consultations diététiques (structure fictive). Un fournisseur présente une gélule d'extrait végétal « anti-graisse » : « Une étude montre que cet extrait réduit de 30 % la graisse abdominale ! » L'étude citée est **fictive**.

Document 1 – L'étude et le produit (exemple fictif)

- Étude chez le **rat** : 20 rats nourris avec un régime très gras, dont 10 reçoivent 500 mg d'extrait par kg de poids corporel et par jour pendant 8 semaines. Graisse abdominale : – 30 % par rapport aux 10 autres rats.
- Gélule vendue : 250 mg d'extrait ; dose conseillée : 2 gélules par jour.
- Conversion des doses entre espèces selon la surface corporelle (guide de la FDA, 2005) : dose équivalente chez l'humain (mg/kg) = dose chez le rat (mg/kg) × 6 / 37.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la dose quotidienne d'extrait apportée par la gélule à un adulte de 70 kg, en mg/kg. (3 pts)
2. Calculez la dose équivalente chez l'humain de la dose donnée au rat, en mg/kg puis en grammes par jour pour 70 kg. Comparez avec la dose de la gélule. (5 pts)
3. Relevez quatre raisons de ne pas transposer ce résultat à vos clients. (4 pts)
4. Rédigez votre réponse au fournisseur et la fiche à ranger dans la base de veille. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 19.31

1. Légendes : 1 Revue systématique ; 2 Essai randomisé ; 3 Cohorte ; 4 Cas-témoins ; 5 Étude transversale ; 6 Avis d'expert, cas isolé.
2. E : **revue systématique** ; C : **essai randomisé** ; A : **cohorte** ; F : **cas-témoins** ; D : **étude transversale** ; B : **cas isolé** (témoignage). Ordre : **E, C, A, F, D, B**.
3. Dans un essai randomisé, le **tirage au sort** répartit au hasard tous les autres facteurs (âge, revenus, habitudes) entre les groupes : la seule différence systématique est l'intervention. Dans une cohorte, les personnes **choisissent** leur comportement ; ceux qui mangent mieux ont souvent d'autres habitudes favorables (facteurs de confusion).

Corrigé – Exercice 19.32

1. Légendes : 1 Objet ; 2 Méthodologie ; 3 Résultats ; 4 Discussion ; 5 Applications ; 6 Forme et source.
2. **Objet** : question claire et utile (atelier de cuisine et HbA1c). **Méthodologie** : point fort, essai **randomisé** multicentrique ; question : les patients savaient-ils dans quel groupe ils étaient, et l'HbA1c était-elle mesurée sans savoir le groupe ? **Résultats** : 148 analysés sur 160, soit 12 perdus de vue (7,5 %) ; l'intervalle (0,1 à 0,7) exclut 0 : effet probable, mais peut-être faible (0,1 point). **Discussion** : le résumé ne cite aucune **limite** (durée courte de 6 mois, pas de mesure à long terme). **Applications** : nos patients ressemblent-ils à ceux de l'étude (âge, niveau de départ d'HbA1c) ? Pouvons-nous organiser des ateliers mensuels ? **Forme et source** : financement par une **enseigne de supermarchés**, qui a intérêt à promouvoir des ateliers en magasin ; chercher la revue, la date et la déclaration des liens d'intérêts.
3. « Les ateliers de cuisine sont une solution efficace **pour tous les diabétiques** » généralise trop. Réécriture : « Chez des patients diabétiques de type 2 suivis dans quatre centres, un atelier de cuisine mensuel a été associé, après 6 mois, à une baisse supplémentaire de l'HbA1c de 0,4 point (IC 95 % : 0,1 à 0,7). L'effet à plus long terme reste à étudier. »

Corrigé – Exercice 19.33

1. Groupe I : 120 − 84 = **36** perdus de vue, soit **30,0 %**. Groupe T : 120 − 102 = **18**, soit **15,0 %**.
2. Per protocole : I : 38 / 84 = **45,2 %** ; T : 30 / 102 = **29,4 %** ; différence : **15,8 points**.
3. Intention de traiter : I : 38 / 120 = **31,7 %** ; T : 30 / 120 = **25,0 %** ; différence : **6,7 points**.
4. Le groupe I a **deux fois plus** de perdus de vue. Les personnes qui abandonnent sont souvent celles qui **ne perdent pas de poids** : en ne gardant que les présents, on garde surtout les réussites, et l'on **surestime** l'effet. L'analyse en **intention de traiter** est la plus prudente : elle respecte le tirage au sort et correspond à la vraie vie (tout le monde ne suit pas le programme jusqu'au bout). Compter tous les perdus de vue comme des échecs est une hypothèse pessimiste ; une étude sérieuse présente plusieurs hypothèses.

Corrigé – Exercice 19.34

1. Risque des buveurs : 240 / 8 000 = **3,0 %**. Risque des autres : 640 / 32 000 = **2,0 %**. Risque relatif : 3,0 / 2,0 = **1,5**. Différence de risque : 3,0 − 2,0 = **1 point**, soit **10 cas de plus pour 1 000 personnes** en 10 ans.
2. Le titre n'est **pas faux** (RR de 1,5, soit + 50 %), mais il ne donne que le **risque relatif**, qui impressionne. Il cache le **risque absolu** : on passe de 20 à 30 cas pour 1 000 personnes en 10 ans. Il présente aussi une association comme une **cause** (« augmentent »).
3. Une cohorte **observe** : les personnes qui boivent beaucoup de boissons sucrées peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au diabète. Facteurs de confusion possibles : le **poids** de départ, l'**activité physique**, le reste de l'**alimentation**, le **niveau socio-économique**, le tabac. Une étude sérieuse les **ajuste**, mais ne peut pas tous les mesurer.

4. Exemple : « Dans une cohorte de 40 000 adultes suivis 10 ans (données fictives), 3 % des personnes buvant au moins une boisson sucrée par jour sont devenues diabétiques, contre 2 % des autres : 10 cas de plus pour 1 000 personnes. Cette association ne prouve pas à elle seule une cause, mais elle va dans le sens des recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 19.35

1. Seule l'étude **C** est significative : son intervalle (0,52 à 0,94) **ne contient pas 1**. Les autres intervalles contiennent 1, même s'ils s'en approchent (E : 0,72 à 1,00 ; F : 0,60 à 1,01).

2. Chaque étude seule a peu de cas et un intervalle large. En **regroupant** les six études, on a beaucoup plus de participants et de cas : l'estimation est plus **précise** et l'intervalle d'ensemble (0,81 à 0,95) devient étroit et exclut 1. La plupart des études vont dans le **même sens** (RR inférieur à 1).

3. Le poids dépend de la **précision** de chaque étude : B et E ont les intervalles les plus étroits (souvent les plus grandes études, avec le plus de cas). C a l'intervalle le plus large : elle compte le moins.

4. RR = 0,88 : le risque de maladie coronarienne est **12 % plus faible** chez les consommateurs réguliers de légumineuses, en relatif. I^2 = 29 % : **hétérogénéité faible à modérée** ; les études ne donnent pas exactement le même résultat (l'étude D va dans l'autre sens), mais les écarts restent limités.

5. Exemples : on regroupe des études d'**observation**, donc la méta-analyse garde leurs **facteurs de confusion** (les consommateurs de légumineuses ont peut-être une alimentation plus saine en général) ; **biais de publication** possible ; définitions différentes de la « consommation régulière » d'une étude à l'autre. Le résultat reste une **association**.

Corrigé – Exercice 19.36

1. 2 × 250 = 500 mg par jour, soit 500 / 70 = **7,1 mg/kg/j**.

2. Dose équivalente chez l'humain : 500 × 6 / 37 = **81,1 mg/kg/j**. Pour 70 kg : 81,1 × 70 = 5 676 mg, soit environ **5,7 g par jour** (soit plus de 22 gélules). La dose de la gélule est environ **11 fois plus faible** que la dose équivalente (81,1 / 7,1 ≈ 11,4). Un calcul naïf (500 mg/kg × 70 kg = 35 g) serait faux, car il ne tient pas compte des différences de métabolisme entre espèces.

3. Raisons : étude chez le **rat**, pas chez l'humain ; régime **très gras** expérimental, sans rapport avec l'alimentation de nos clients ; **10 rats** par groupe ; dose **11 fois** plus forte que celle de la gélule ; durée courte ; étude citée par le **vendeur** ; aucune donnée de **sécurité** chez l'humain ; « graisse abdominale » du rat n'est pas un critère de santé humain.

4. Réponse : « Je ne peux pas conseiller ce produit sur cette base : l'étude porte sur 10 rats, avec un régime très gras, et une dose équivalente environ 11 fois plus élevée que celle de votre gélule. Avez-vous des essais chez l'humain, publiés dans une revue relue par des pairs ? » Fiche : référence de l'étude ; mots-clés : compléments alimentaires, perte de poids, étude animale ; résumé ; intérêt : **aucun pour la pratique** ; usage : réponse au fournisseur ; à surveiller : essais chez l'humain, avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur cet extrait.

Partie 7 – Du résultat à l'information du public

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer l'« embellissement » (spin) d'un résultat dans un résumé.
- Suivre une information de l'article au communiqué, puis à la presse.
- Présenter un risque en fréquences naturelles.
- Lire la structure d'un avis d'agence.

- Relier une recommandation à son grade.
- Répondre à une rumeur alimentaire en s'appuyant sur la veille.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **spin** consiste à présenter un résultat de façon plus favorable que ce que montrent les données (par exemple, mettre en avant un critère secondaire quand le critère principal n'est pas significatif).
- Les **exagérations** de la presse naissent souvent dès le **communiqué de presse** (Sumner et coll., *BMJ*, 2014).
- Les **fréquences naturelles** (« 32 personnes sur 1 000 ») se comprennent mieux que les pourcentages et les probabilités conditionnelles.
- Un **avis d'agence** suit un plan : saisine (la question), contexte, méthode d'expertise, analyse, conclusions et recommandations.
- Grades de la HAS : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve), **AE** (accord d'experts).

Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation sur la lecture critique pour l'équipe d'un service de nutrition clinique (fictif). Vous partez d'une étude réelle sur le spin, puis d'un résumé fictif.

Document 1 – Une étude sur le spin (source réelle)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006, dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. On trouvait du spin dans le **titre** de 13 articles, dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles.

Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.

Document 2 – Un résumé (étude fictive)

« Un yaourt enrichi en probiotiques a été comparé à un yaourt nature chez 200 adultes pendant 12 semaines. Critère principal : nombre de jours de rhume. Pas de différence significative (p = 0,41). En revanche, chez les femmes de plus de 50 ans (analyse non prévue au départ), la durée des rhumes était plus courte (p = 0,04). **Conclusion : ce yaourt renforce l'immunité et peut être recommandé aux seniors.** »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'articles avec du spin dans le titre, les résultats et la conclusion du résumé. Que montre la progression ? (4 pts)
2. Relevez trois formes de spin dans le document 2. (4 pts)
3. Réécrivez une conclusion honnête. (2 pts)
4. Proposez une règle de lecture à retenir pour l'équipe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bureau d'une association de diététiciens (fictive) veut écrire des communiqués de presse sur ses travaux. Vous présentez les résultats d'une étude réelle, puis un exemple fictif.

Document 1 – Exagérations dans les communiqués et dans la presse (source réelle)

Étude de 462 communiqués de presse sur la santé, publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et de 668 articles de presse qui en ont parlé.

Type d'exagération	Communiqués exagérés	Presse exagérée quand le communiqué l'était	Presse exagérée quand le communiqué ne l'était pas
Conseil donné au lecteur	40 %	58 %	17 %
Lien de cause à effet	33 %	81 %	18 %
Passage de l'animal à l'humain	36 %	86 %	10 %

Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.

Document 2 – Une chaîne d'information (exemple fictif)

- **Article** : « Chez la souris, un régime riche en polyphénols de pomme est associé à une moindre inflammation intestinale. »
- **Communiqué** : « Les polyphénols de pomme réduisent l'inflammation de l'intestin. »
- **Presse** : « Une pomme par jour guérit les maladies inflammatoires de l'intestin ! »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque type d'exagération, combien de fois la presse exagère plus souvent quand le communiqué exagère. (3 pts)
2. Concluez : qui porte une part de responsabilité dans les titres exagérés ? (2 pts)
3. Analysez le document 2 : à chaque étape, quelle exagération est ajoutée ? Utilisez les types du document 1. (5 pts)
4. Proposez trois règles pour les communiqués de l'association. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez deux messages pour des publics différents dans un centre hospitalier (fictif). Toutes les données sont **fictives**.

Document 1 – Deux situations (données fictives)

- **Situation A (patients).** Sans changement d'alimentation, 40 personnes sur 1 000 ayant un certain profil développent la maladie en 10 ans. Une modification alimentaire réduit ce risque de 20 % (risque relatif 0,80).
- **Situation B (soignants).** Un outil de dépistage de la dénutrition est utilisé dans un service où 20 % des patients sont dénutris. L'outil repère 85 % des patients dénutris (sensibilité) et classe correctement 80 % des patients non dénutris (spécificité).

À vous de jouer – Questions

1. Situation A : calculez le nombre de cas pour 1 000 personnes avec la modification, le nombre de cas évités et le nombre de personnes qui doivent changer leur alimentation pour éviter un cas. (4 pts)
2. Rédigez le message aux patients en fréquences naturelles. (2 pts)
3. Situation B : pour 1 000 patients, construisez le tableau des vrais positifs, faux négatifs, faux positifs et vrais négatifs. Calculez la part de patients réellement dénutris parmi ceux que l'outil repère. (5 pts)
4. Expliquez aux soignants ce que signifie ce résultat et ce qu'ils doivent faire après un test positif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne de PMI (fictive) a reçu un long avis d'une agence d'expertise. Elle n'a que 15 minutes pour en tirer l'essentiel. Voici les titres et quelques phrases d'un avis **fictif**, construit sur le plan habituel.

Document 1 – Extraits d'un avis (exemple fictif)

- **A.** « L'agence a été saisie le 4 mars par la direction générale de la santé sur la question suivante : … »
- **B.** « Les experts ont mené une revue systématique des études publiées entre 2010 et 2024 ; 46 études ont été retenues. »
- **C.** « Des signalements récents font état de consommations élevées de ce produit chez les jeunes enfants. »
- **D.** « L'agence recommande de ne pas proposer ce produit aux enfants de moins de 3 ans. »
- **E.** « Les données disponibles chez l'enfant sont peu nombreuses ; aucune étude de plus de 6 mois n'a été trouvée. »
- **F.** « Les experts ont rempli une déclaration publique d'intérêts ; leurs liens ont été analysés. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque extrait à une partie de l'avis : saisine, contexte, méthode, analyse et limites, conclusions et recommandations, indépendance. (6 pts)
2. Indiquez dans quel ordre la diététicienne pressée doit lire l'avis, et pourquoi. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'extrait E ne remet pas en cause la recommandation D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez une recommandation de bonne pratique **fictive** sur la prise en charge nutritionnelle d'une maladie. Chaque recommandation porte un grade, selon le système de la HAS.

Document 1 – Quatre recommandations et leurs preuves (exemple fictif)

- **R1.** Proposer un suivi diététique individuel. Appuyée sur plusieurs essais randomisés de bonne qualité aux résultats concordants.
- **R2.** Évaluer le statut nutritionnel à chaque consultation. Aucune étude ; le groupe de travail est unanime.
- **R3.** Limiter un aliment particulier. Appuyée sur des études de cohorte bien menées.
- **R4.** Proposer un complément en vitamine. Appuyée sur une étude cas-témoins et deux petites séries de cas.

Système de gradation : HAS, « Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique », état des lieux, avril 2013.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la signification des grades A, B, C et AE. (4 pts)
2. Attribuez un grade à chaque recommandation et justifiez. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un grade C ou AE ne veut pas dire que la recommandation est fausse ou facultative. (3 pts)
4. Dites ce que votre veille doit surveiller pour les recommandations R3 et R4. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien d'un service de restauration scolaire (fictif). Dans le groupe de messagerie des parents d'une école, un message circule : « Les repas de la cantine sont réchauffés au micro-ondes, ce qui détruit toutes les vitamines et rend la nourriture cancérigène. Partagez ! » Le message a été partagé 140 fois en deux jours. En réalité, la cuisine centrale livre en liaison froide et les plats sont remis en température dans des fours mixtes.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez la méthode SIFT à ce message. (4 pts)
2. Indiquez les sources fiables à consulter pour répondre sur la cuisson et les vitamines, et sur les matériaux au contact des aliments. (3 pts)
3. Rédigez la réponse aux parents (8 à 10 lignes) : ton respectueux, faits vérifiables, une ouverture (par exemple, une visite de la cuisine). (6 pts)
4. Expliquez comment cette situation doit être intégrée à votre veille et à votre évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 19.37

1. Titre : 13 / 72 = **18 %** ; résultats du résumé : 27 / 72 = **37,5 %** ; conclusion du résumé : 42 / 72 = **58,3 %**. Plus on avance vers la **conclusion**, plus le spin est fréquent : c'est la partie que l'on lit le plus vite, et la plus « embellie ». Il faut donc lire les **résultats** du critère principal avant la conclusion.
2. Spin : 1) le **critère principal** non significatif est relégué derrière une analyse secondaire ; 2) le résultat repose sur un **sous-groupe** (femmes de plus de 50 ans) **non prévu** au départ, avec un p à 0,04, fragile quand on multiplie les sous-groupes ; 3) la conclusion **généralise** (« renforce l'immunité ») et donne un **conseil** (« peut être recommandé aux seniors ») que l'étude ne justifie pas.
3. « Chez 200 adultes, ce yaourt n'a pas réduit le nombre de jours de rhume par rapport à un yaourt nature. L'effet observé dans un sous-groupe non prévu doit être vérifié par un nouvel essai. »
4. « On lit d'abord le **critère principal** et son résultat, puis on compare avec la conclusion. Si la conclusion parle d'autre chose, on se méfie. »

Corrigé – Exercice 19.38

1. Conseil : 58 / 17 ≈ **3,4 fois** plus souvent ; cause : 81 / 18 = **4,5 fois** ; animal vers humain : 86 / 10 = **8,6 fois**.
2. Les exagérations ne viennent pas seulement des **journalistes** : elles naissent souvent dans le **communiqué**, écrit par les services de communication avec les chercheurs. Les auteurs ont donc une responsabilité ; inversement, un communiqué exact limite les exagérations dans la presse.
3. Article → communiqué : **passage de l'animal à l'humain** (la souris disparaît) et **lien de cause** (« associé à » devient « réduisent »). Communiqué → presse : **conseil** ajouté (« une pomme par jour »), passage d'un **extrait** de polyphénols à un **aliment** entier, et promesse de **guérison** d'une maladie.
4. Règles : garder les **mots exacts** de l'étude (« associé à » pour une étude d'observation) ; indiquer **chez qui** (animal, humain, nombre de personnes) et le **type d'étude** ; ne donner un **conseil** que s'il est appuyé par des recommandations ; faire relire le communiqué par les auteurs ; ajouter un paragraphe « limites ».

Corrigé – Exercice 19.39

1. Avec la modification : 40 × 0,80 = **32 cas pour 1 000**. Cas évités : 40 − 32 = **8 pour 1 000**. Nombre de personnes à faire changer pour éviter un cas : 1 000 / 8 = **125**.
2. « Sur 1 000 personnes comme vous, 40 auront cette maladie dans les 10 ans sans rien changer. Si elles changent leur alimentation, elles seront environ 32. Cela fait 8 malades de moins sur 1 000. »
3. Tableau pour 1 000 patients :

	Dénutris (200)	Non dénutris (800)	Total
Outil positif	170 (vrais positifs)	160 (faux positifs)	330
Outil négatif	30 (faux négatifs)	640 (vrais négatifs)	670

Calculs : 200 × 0,85 = 170 ; 800 × 0,80 = 640 ; 800 − 640 = 160. Parmi les 330 patients repérés, 170 sont dénutris : 170 / 330 = **51,5 %** (valeur prédictive positive).

4. Un patient repéré par l'outil n'a qu'**environ une chance sur deux** d'être vraiment dénutri. L'outil sert à **dépister**, pas à **diagnostiquer** : après un test positif, il faut une **évaluation complète** (critères de diagnostic, avis de la diététicienne). À l'inverse, un test négatif est rassurant : 640 / 670 = 95,5 % des négatifs ne sont pas dénutris.

Corrigé – Exercice 19.40

1. A : **saisine** ; C : **contexte** ; B : **méthode** ; E : **analyse et limites** ; D : **conclusions et recommandations** ; F :

indépendance de l'expertise.

2. Ordre conseillé : **saisine** (quelle question ?), puis **conclusions et recommandations** (que faut-il faire ?), puis **limites** (jusqu'où va la réponse ?), puis méthode si nécessaire. La diététicienne sait vite ce qui change pour sa pratique et avec quelle solidité.
3. Une agence peut recommander la **prudence** justement parce que les données manquent : en l'absence de preuve de sécurité chez le jeune enfant, et devant des consommations élevées, on applique un principe de **précaution**. L'extrait E explique le **niveau de preuve** de la recommandation ; il ne la contredit pas.

Corrigé – Exercice 19.41

1. **A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais). **B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées). **C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas). **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études, sur la base de l'avis du groupe de travail.
2. R1 : **A** (plusieurs essais randomisés de bonne qualité et concordants). R2 : **AE** (aucune étude, accord unanime). R3 : **B** (cohortes bien menées). R4 : **C** (cas-témoins et séries de cas).
3. Le grade dit **quelle force de preuve** soutient la recommandation, pas si elle est utile. Beaucoup de gestes simples (évaluer le statut nutritionnel) n'ont jamais été testés par un essai, car ils sont évidents ou difficiles à étudier ; l'accord d'experts reste la meilleure base disponible.
4. R3 et R4 reposent sur des preuves moyennes ou faibles : la veille surveille les **nouveaux essais** ou **revues systématiques** sur ces sujets, qui peuvent confirmer ou modifier la recommandation, ainsi que la **mise à jour** de la recommandation elle-même.

Corrigé – Exercice 19.42

1. **Stop** : ne pas réagir sous le coup de l'émotion ; ne pas partager. **Investigate the source** : le message n'a pas d'auteur ni de source. **Find better coverage** : les agences sanitaires ne disent pas que le micro-ondes rend la nourriture cancérigène. **Trace claims** : le message part d'une idée reçue ancienne ; de plus, il est **faux sur les faits** (la cuisine utilise des fours mixtes).
2. Cuisson et vitamines : l'**ANSES**, les ressources de l'**EFSA** et des tables de composition (pertes à la cuisson). Matériaux au contact des aliments : l'**ANSES**, l'**EFSA** et la **DGCCRF** (règles sur les matériaux au contact des denrées). Les fiches techniques des fours et le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine centrale.
3. Exemple : « Chers parents, nous avons vu le message qui circule sur les repas de la cantine, et nous comprenons votre inquiétude. Les repas sont préparés à la cuisine centrale, refroidis rapidement, puis remis en température à l'école dans des fours professionnels, et non au micro-ondes. Toute cuisson et tout réchauffage font perdre une partie de certaines vitamines sensibles à la chaleur, quel que soit l'appareil ; c'est pourquoi nos menus comportent chaque jour des crudités ou des fruits. Les agences sanitaires ne considèrent pas le réchauffage au micro-ondes comme cancérigène. Nous vous proposons de visiter la cuisine centrale le [date] et de rencontrer l'équipe. Pour toute question, vous pouvez nous écrire à [adresse]. »
4. Veille **sociétale** : noter la rumeur (date, canal, nombre de partages, thème) dans la base ; surveiller si elle revient ou se transforme ; préparer une **fiche réponse** réutilisable. Évaluation : suivre le nombre de questions des parents dans le mois suivant, la participation à la visite, et l'éventuelle baisse de fréquentation de la cantine.

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Rédiger une fiche de lecture d'un article.
- Rédiger une synthèse de plusieurs documents qui ne disent pas la même chose.
- Présenter oralement une veille en quelques minutes.
- Construire un plan de veille complet dans un budget de temps.
- Relire une note de veille et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **fiche de lecture** contient : référence complète, question, type d'étude et population, résultats chiffrés, limites, niveau de preuve, intérêt pour la pratique.
- Une **synthèse** ne résume pas les documents l'un après l'autre : elle répond à **une question**, compare les sources, explique les **désaccords** et conclut avec prudence.
- Un **plan de veille** tient dans un tableau : axe, question, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateurs.
- À l'oral, on annonce la **question**, on donne **peu de chiffres** mais exacts et datés, on dit **ce que cela change**.

Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche de lecture d'un article pour la base de veille d'un réseau gériatrique (fictif). L'article est **fictif**.

Document 1 – Notes prises pendant la lecture (article fictif)

Revue de gériatrie, publié en mars 2026, 4 auteurs d'un centre hospitalier universitaire, DOI indiqué. Essai randomisé dans 6 EHPAD : 240 résidents constipés, tirés au sort entre pain complet et compote de pruneaux chaque jour (n = 120) ou alimentation habituelle (n = 120), pendant 8 semaines. Critère principal : nombre de selles par semaine. Résultat : + 1,2 selle par semaine dans le groupe intervention (IC 95 % : 0,6 à 1,8). 18 perdus de vue. Laxatifs moins utilisés (critère secondaire). Pas d'aveugle possible. Financement : fondation publique. Les auteurs concluent que l'enrichissement en fibres est « une option simple à proposer ».

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez la fiche de lecture avec les rubriques de l'encadré « À connaître ». (7 pts)
2. Calculez la part de perdus de vue et dites si elle menace le résultat. (2 pts)
3. Indiquez le mot-clé principal de la liste fermée que vous choisiriez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé scolaire (fictive) vous pose la question : « Faut-il dire aux collégiens de prendre un petit-déjeuner pour être plus attentifs en classe ? » Vous avez trouvé trois documents, tous **fictifs**.

Document 1 – Trois documents (exemples fictifs)

- **D1.** Étude transversale sur 3 000 collégiens : ceux qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes. Les auteurs signalent que ces élèves viennent plus souvent de familles favorisées.
- **D2.** Essai randomisé sur 180 collégiens pendant 4 semaines : petit-déjeuner servi au collège ou non ; tests d'attention en fin de matinée un peu meilleurs dans le groupe petit-déjeuner (différence significative, mais faible).
- **D3.** Article d'un magazine : « Sauter le petit-déjeuner fait grossir et rend idiot, prouvent les scientifiques ! » Aucune référence.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les trois documents par niveau de preuve et justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi D1 ne suffit pas à conclure et ce que D2 apporte de plus. (3 pts)
3. Rédigez une synthèse de 8 lignes qui répond à la question de l'infirmière. (4 pts)
4. Indiquez quelle information manque encore pour bien répondre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter en 5 minutes, à la réunion d'équipe d'une maison de santé (fictive), la veille du trimestre sur l'alimentation de la femme enceinte. Votre base contient 23 informations retenues.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi vous ne présentez pas les 23 informations, et comment vous choisissez les 3 ou 4 à présenter. (3 pts)
2. Proposez le déroulé minuté de l'intervention de 5 minutes. (4 pts)
3. Donnez trois règles pour présenter un chiffre à l'oral. (3 pts)
4. Un médecin demande : « Cette étude, elle est solide ? » Proposez une réponse type en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale et solidaire (fictive) emploie une diététicienne à mi-temps. Elle anime des ateliers cuisine, conseille les bénéficiaires, et participe au projet alimentaire territorial de la communauté de communes. La directrice lui accorde **2 heures par semaine** de veille.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille adaptés à cette structure, avec une question de veille pour chacun. (4 pts)
2. Construisez le plan de veille sous forme de tableau : axe, sources, outils, fréquence, destinataires, temps par semaine. (6 pts)
3. Vérifiez que votre plan respecte les 2 heures par semaine, en gardant du temps pour le stockage et la diffusion. (2 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le plan au bout d'un an. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant l'envoi, la responsable d'un service de diététique (fictif) vous demande de relire la note de veille d'octobre rédigée par une collègue. Les études citées dans les informations 2 et 4 sont **fictives**.

Document 1 – La note à relire (extrait)

Note de veille n° 14 – octobre

1. **Étiquetage** : le règlement INCO n° 1169/2011 impose la déclaration nutritionnelle depuis 2011.
2. **Fruits à coque** : une étude montre qu'une poignée de noix par jour réduit le risque cardiovasculaire de 30 %. Nous conseillons donc à tous nos patients une poignée de noix par jour, y compris aux patients allergiques s'ils commencent par de petites quantités.
3. **Édulcorants** : l'OMS a recommandé en mai 2023 de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids.
4. **Vitamine D** : selon un preprint publié hier, la vitamine D guérit la dépression. À diffuser aux patients.
5. **Loi EGalim** : depuis le 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en restauration collective publique.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque information, dites si elle est exacte, à corriger ou à supprimer, et justifiez. (8 pts)
2. Repérez l'information dangereuse et expliquez le danger. (2 pts)
3. Réécrivez l'information 2 de façon exacte. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets. (3 pts)
4. Proposez une liste de vérification en cinq points à appliquer avant chaque envoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **centre de santé municipal des Quatre-Vents** (structure fictive), qui réunit 4 médecins, 2 infirmières, une diététicienne à temps partiel et une secrétaire. Le centre suit 410 patients diabétiques de type 2. Depuis plusieurs mois, les patients posent des questions sur les édulcorants : « L'aspartame donne le cancer, c'est l'OMS qui l'a dit » ; « Je bois du soda light toute la journée, c'est sans sucre donc sans risque ? ». Le Dr Benali (fictif), médecin coordinateur, vous confie trois missions : **organiser la veille** de l'équipe, **lire de façon critique** les informations sur les édulcorants, et **préparer un atelier** « Le goût sucré, autrement » pour les patients.

Document 1 – Les sources suivies actuellement par l'équipe (données fictives, relevé sur un mois)

Source	Outil	Éléments reçus par mois	Temps passé par mois (min)	Éléments utilisés en 6 mois
Alerte d'un moteur de recherche « sucre »	Alerte de moteur	220	180	0
Haute Autorité de santé	Lettre d'information	6	20	2
ANSES	Lettre d'information	8	25	3
Groupe de patients sur un réseau social	Consultation	300	240	1
Revue professionnelle de diététique	Abonnement	1 numéro	60	4
PubMed *sweeteners*, sans filtre	Alerte sur une base	90	150	1
Santé publique France	Lettre d'information	4	15	2

Document 2 – Un article de presse en ligne (exemple fictif)

« **L'aspartame est cancérigène : l'OMS le confirme !** Une grande étude française sur 100 000 personnes prouve que les édulcorants augmentent le risque de cancer. Jetez vos sodas light ! » L'article ne donne aucune référence et ne cite aucun chiffre.

Document 3 – Ce que disent les sources d'origine (données réelles, à citer avec leur date)

- **Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), 14 juillet 2023** : le CIRC classe l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le CIRC évalue le **danger** (le produit peut-il causer un cancer ?), pas le **risque** aux doses habituelles. Le JECFA, qui évalue le **risque**, maintient la dose journalière admissible (DJA) de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**.
- **Cohorte NutriNet-Santé** (Debras C. et coll., *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950) : 102 865 adultes français suivis de 2009 à 2021 (suivi médian 7,8 ans) ; 3 358 cancers. Chez les plus forts consommateurs d'aspartame, par rapport aux non-consommateurs : rapport de risques instantanés (HR) **1,15** (IC 95 % : 1,03 à 1,28). Les auteurs signalent des biais possibles de sélection, de confusion résiduelle et de causalité inverse.
- **OMS, ligne directrice du 15 mai 2023** : recommandation **conditionnelle** de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids ou réduire le risque de maladies non transmissibles. Elle ne s'applique pas aux personnes déjà diabétiques.

Document 4 – Deux patients (données fictives)

- **Mme L.**, 72 kg, boit 1,5 L par jour d'un soda « light ». Teneur en aspartame indiquée par le fabricant : 300 mg par litre (valeur fictive).
- **Le petit-fils de Mme L.**, 18 kg, boit 0,5 L par jour du même soda pendant les vacances.

Document 5 – Trois goûters comparés à l'atelier (par portion)

- **Goûter habituel** : crème dessert à la vanille 125 g ; biscuit sec nature 20 g ; boisson gazeuse sucrée 330 g.
- **Goûter « édulcoré »** : dessert lacté aromatisé avec édulcorants 125 g ; biscuit sec au chocolat avec édulcorants 20 g ; boisson gazeuse avec édulcorants 330 g.
- **Goûter de l'atelier** : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net ; cannelle 1 g ; amandes 15 g ; eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229)	103	2,98	16,2	13,8	2,88	0,11	0,12
Biscuit sec nature (24001)	438	7,13	74,9	25,4	11,5	3,3	0,74
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	34,5	0,0016	8,28	8,28	0,043	0,017	0,0067
Spécialité laitière ou dessert lacté, aromatisé, à faible teneur en matière grasse, sucré, avec édulcorants, rayon frais (19686)	75,5	3,8	11,9	9,76	1,05	1,73	0,2
Biscuit sec au chocolat, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, enrichi en vitamines (24012)	448	6,78	64,6	1,72	21,8	3,71	0,57
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sans sucres ajoutés, avec édulcorants (18001)	0,23	0,000022	0,063	0,054	0,000022	< 0,1	0,013
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000)	615	18,8	9,51	4,2	51,3	12,5	< 0,013

Prix (fictifs, 2026) : crème dessert 0,35 € le pot ; dessert lacté édulcoré 0,40 € le pot ; biscuit sec nature 2,40 € le kilo ; biscuit édulcoré 6,50 € le kilo ; canette de 330 mL 0,45 € (sucrée ou édulcorée) ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo (rendement 0,90) ; cannelle 40 € le kilo ; amandes 16 € le kilo.

Projet : 3 ateliers de 10 patients ; le goûter de l'atelier est préparé pour les 10 patients et les 2 animatrices ; un livret de 30 exemplaires à 1,50 € ; contributions valorisées par atelier : diététicienne 3 heures à 30 € de l'heure, infirmière 2 heures à 28 € de l'heure, salle municipale 30 €.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- OMS, ligne directrice sur les sucres (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Santé publique France, repères pour les adultes (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable ; consommer des fruits à coque sans sel ajouté en petite quantité.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Organiser la veille (14 points)

1. Proposez trois axes de veille pour l'équipe, avec une question de veille pour chacun, en lien avec la demande du Dr Benali. (3 pts)

2. Exploitez le document 1 : temps total par mois, nombre d'éléments reçus, temps par élément utilisé sur 6 mois. Proposez une nouvelle organisation (garder, modifier, supprimer) et calculez le nouveau temps mensuel, en estimant le temps des sources modifiées. (5 pts)

3. Construisez la matrice de diffusion de l'information « le CIRC classe l'aspartame en 2B » pour trois destinataires de l'équipe. (3 pts)

4. Rédigez la fiche de la base documentaire pour l'étude NutriNet-Santé du document 3. (3 pts)

Partie B – Lire et juger (14 points)

5. Expliquez la différence entre **danger** et **risque**, à partir des rôles du CIRC et du JECFA. (3 pts)

6. Analysez l'étude NutriNet-Santé : type d'étude, signification du HR et de son intervalle, part de participants ayant eu un cancer, limites. Concluez sur ce que l'étude montre et ne montre pas. (5 pts)

7. Calculez la dose d'aspartame en mg/kg/j et la part de la DJA pour Mme L. et pour son petit-fils, puis le volume de soda qui ferait atteindre la DJA à Mme L. Commentez. (3 pts)

8. Relevez dans le document 2 quatre erreurs ou exagérations, en vous appuyant sur le document 3. (3 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

9. Calculez la valeur nutritionnelle des trois goûters (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie. Comparez et commentez. (4 pts)

10. Calculez le coût par portion de chaque goûter, puis le budget des 3 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, coût total et coût par participation. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la note de veille de l'équipe sur les édulcorants (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Rédigez votre réponse orale à Mme L. (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 19.43

1. **Référence** : [auteurs], [titre], Revue de gériatrie, mars 2026, [volume, pages], DOI [numéro]. **Question** : l'ajout quotidien de pain complet et de compote de pruneaux augmente-t-il le nombre de selles chez des résidents d'EHPAD constipés ? **Type d'étude et population** : essai randomisé dans 6 EHPAD, 240 résidents constipés, 8 semaines, sans aveugle. **Résultats** : + 1,2 selle par semaine (IC 95 % : 0,6 à 1,8) ; moins de laxatifs (critère secondaire). **Limites** : pas d'aveugle (les soignants savent qui reçoit l'intervention) ; durée courte ; 18 perdus de vue. **Niveau de preuve** : bon (essai randomisé, financement public), à confirmer par d'autres essais. **Intérêt pour la pratique** : mesure simple et peu coûteuse à proposer dans les EHPAD du réseau, en surveillant l'hydratation et la tolérance.
2. 18 / 240 = **7,5 %** de perdus de vue : part faible, qui menace peu le résultat, surtout si elle est proche dans les deux groupes et si l'analyse est faite en intention de traiter.
3. « **Constipation** » (avec « personne âgée » et « fibres » comme mots-clés secondaires).

Corrigé – Exercice 19.44

1. **D2** (essai randomisé) > **D1** (étude transversale) > **D3** (article de presse sans référence, pas une étude).
2. D1 montre une **association** à un moment donné ; les élèves qui déjeunent viennent plus souvent de familles **favorisées**, qui peuvent aussi expliquer les meilleures notes (facteur de **confusion**). D2 compare des groupes **tirés au sort** : la seule différence systématique est le petit-déjeuner ; il montre un **effet** sur l'attention, mais faible et sur 4 semaines.
3. Exemple : « Les études disponibles ne disent pas toutes la même chose. Une grande enquête montre que les collégiens qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes, mais ils viennent aussi plus souvent de familles favorisées : on ne peut pas conclure à un effet du repas. Un essai, plus solide, a montré une petite amélioration de l'attention en fin de matinée quand un petit-déjeuner est servi. On peut donc encourager un petit-déjeuner, sans le présenter comme une solution miracle, et sans culpabiliser les élèves qui n'ont pas faim le matin ou n'ont pas accès à un petit-déjeuner. L'article de magazine n'apporte aucune preuve. »
4. Il manque une **revue systématique** ou une recommandation d'agence sur le sujet ; il manque aussi des données sur les élèves du collège (combien ne déjeunent pas, pourquoi : faim, temps, moyens).

Corrigé – Exercice 19.45

1. Présenter 23 informations en 5 minutes, c'est 13 secondes par information : personne ne retient rien. On choisit les 3 ou 4 qui **changent la pratique** de l'équipe ou qui répondent à une **question fréquente** des patientes, et qui viennent de **sources solides** ; les autres restent accessibles dans la base.
2. Exemple : 0 à 0 min 30 : la question de veille et la période ; 0 min 30 à 4 min : trois informations, environ 1 minute chacune (quoi, source datée, ce que cela change) ; 4 à 4 min 30 : ce qui est à surveiller au prochain trimestre ; 4 min 30 à 5 min : questions, et où trouver le reste (base, note écrite).
3. Règles : **un seul** chiffre par information ; l'arrondir et le dire en **fréquence** (« 8 femmes sur 100 ») ; toujours dire **chez qui** et **d'où vient** le chiffre (source, année) ; préférer le **risque absolu** au risque relatif seul.
4. Exemple : « C'est un essai randomisé sur [nombre] femmes, publié dans une revue relue par des pairs, donc un bon niveau de preuve ; mais il n'a été mené que dans [pays], il faut voir s'il est confirmé. Les recommandations actuelles de [agence] ne changent pas pour l'instant. »

Corrigé – Exercice 19.46

1. Exemples : **aide alimentaire et précarité** (réglementaire et institutionnelle) : « Quelles règles et quels financements concernent l'épicerie (dons, normes, appels à projets) ? » ; **recommandations**

nutritionnelles à petit budget (scientifique et professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils permettent de bien manger avec peu de moyens, pour les ateliers ? » ; **projet alimentaire territorial** (institutionnelle) : « Quelles actions et quelles réunions du PAT concernent l'accès des bénéficiaires à une alimentation de qualité ? » ; **idées reçues des bénéficiaires** (sociétale) : « Quelles tendances et rumeurs alimentaires circulent auprès des bénéficiaires ? »

2. Exemple de plan :

Axe	Sources	Outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Aide alimentaire	Légifrance, ministère chargé des solidarités, réseau national des épiceries solidaires	Lettre, consultation	Mensuelle	Directrice	15 min
Petit budget	Santé publique France, ANSES, revue professionnelle	Lettres, flux RSS	Mensuelle	Équipe, bénévoles	30 min
PAT	Site de la communauté de communes, réseau national des PAT	Lettre, réunions	Selon calendrier	Directrice	15 min
Idées reçues	Questions des bénéficiaires (cahier), quelques comptes populaires	Cahier, consultation	Mensuelle	Équipe	15 min

3. Temps de collecte : 15 + 30 + 15 + 15 = **75 min** ; il reste 120 − 75 = **45 min** pour le rangement dans la base (15 min) et la diffusion (note mensuelle et transmissions, 30 min) : le plan tient en **2 heures**.

4. Exemples : nombre d'informations **utilisées** (atelier, document, dossier de financement) dans l'année ; nombre de **dossiers de financement** déposés grâce à la veille ; **temps réel** passé, relevé un mois par trimestre ; satisfaction de l'équipe et des bénévoles.

Corrigé – Exercice 19.47

1. Information 1 : **à corriger** ; le règlement date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014 et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le **13 décembre 2016**. Information 2 : **à corriger** ; « une étude » sans référence, « réduit » (cause) alors qu'il s'agit peut-être d'une étude d'observation, risque relatif sans risque absolu, et un conseil **dangereux** pour les allergiques. Information 3 : **exacte** ; ajouter la référence (OMS, ligne directrice du 15 mai 2023), le caractère **conditionnel** de la recommandation et le fait qu'elle ne vise pas les personnes déjà diabétiques. Information 4 : **à supprimer** ; un preprint n'est pas relu par des pairs, « guérit » est une exagération, et une information non vérifiée ne se diffuse pas aux patients. Information 5 : **exacte** ; ajouter la référence (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et préciser l'extension à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 (loi Climat et résilience).

2. Information 2 : conseiller des noix aux personnes **allergiques**, même en petite quantité, peut provoquer une **réaction grave** (choc anaphylactique). Une introduction progressive d'un allergène ne se fait que dans un cadre médical, sur décision de l'allergologue.

3. Exemple : « **Fruits à coque** : une [type d'étude] menée chez [nombre] adultes [pays], publiée dans [revue] en [année], associe la consommation d'une petite poignée de fruits à coque par jour à un risque cardiovasculaire plus faible ([risque absolu dans chaque groupe]). Cela va dans le sens du PNNS, qui conseille une petite poignée de fruits à coque sans sel ajouté par jour. Ne concerne pas les personnes allergiques. »

4. Liste : 1) chaque information a une **référence complète** et datée ; 2) la **date d'application** des textes est vérifiée (version consolidée) ; 3) le **type d'étude** et le vocabulaire correspondent (« associé à » ou « réduit ») ; 4) aucun **conseil** n'est donné sans recommandation officielle, et les **contre-indications** sont signalées ; 5) les **preprints** et les sources faibles ne sont pas diffusés au public ; relecture par une seconde

personne.

Corrigé – Exercice 19.48

Partie A – Organiser la veille

1. Exemples : **édulcorants et sucres** (scientifique et réglementaire) : « Que disent les agences (OMS, EFSA, ANSES, CIRC) sur la sécurité et l'intérêt des édulcorants, pour répondre aux patients diabétiques ? » ; **éducation thérapeutique et alimentation du diabète** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils d'éducation sont publiés pour les patients diabétiques de type 2, pour les ateliers du centre ? » ; **idées reçues des patients** (sociétale) : « Quelles informations sur le sucre et les édulcorants circulent auprès des patients, pour préparer des réponses ? »

2. **Bilan du document 1**

Temps : 180 + 20 + 25 + 240 + 60 + 150 + 15 = **690 min par mois** (11 h 30). Éléments reçus : 220 + 6 + 8 + 300 + 1 + 90 + 4 = **629 par mois**. Éléments utilisés en 6 mois : 0 + 2 + 3 + 1 + 4 + 1 + 2 = **13**. Temps sur 6 mois : 690 × 6 = 4 140 min, soit 4 140 / 13 ≈ **318 min** (plus de 5 heures) par élément utilisé.

Nouvelle organisation (exemple) : **supprimer** l'alerte de moteur (180 min, rien utilisé) ; **garder** HAS (20 min), ANSES (25 min), revue (60 min), Santé publique France (15 min) ; **modifier** le groupe de patients : une consultation de 30 min par mois, en veille sociétale ; **modifier** l'alerte PubMed : ajouter des filtres (humain, revues systématiques et essais, *diabetes*), environ 15 éléments et 30 min par mois.

Nouveau temps : 20 + 25 + 30 + 60 + 30 + 15 = **180 min par mois** (3 h), soit **74 % de temps en moins**. Si l'on garde les 13 éléments utiles, cela fait environ 180 × 6 / 13 ≈ 83 min par élément utilisé. Ces temps sont des estimations à vérifier.

3. **Matrice de diffusion**

Qui	Quoi	Pourquoi	Comment	Quand
Médecins	Classement 2B (danger, preuves limitées) et DJA maintenue par le JECFA (risque), références datées	Répondre de façon juste et cohérente aux patients	Note de veille, point en réunion d'équipe	Dans la semaine (question fréquente des patients)
Infirmières	Même information, avec une phrase type pour les patients	Répondre en consultation et en éducation thérapeutique	Fiche réponse d'une page	Dans la semaine
Secrétaire	Message court : « Le centre a fait le point, parlez-en à votre médecin ou à la diététicienne »	Orienter les patients qui appellent	Courriel court	Dans la semaine

4. **Fiche de la base** : **Référence** : Debras C. et coll., *Artificial sweeteners and cancer risk: results from the NutriNet-Santé population-based cohort study*, *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950, DOI 10.1371/journal.pmed.1003950, consulté le [date]. **Mots-clés** : édulcorants ; cancer ; cohorte. **Résumé** : cohorte de 102 865 adultes français, suivi médian 7,8 ans ; les plus forts consommateurs d'aspartame ont un risque de cancer un peu plus élevé (HR 1,15 ; IC 95 % : 1,03 à 1,28). **Intérêt** : étude citée par les médias et les patients ; association, pas preuve de cause. **Usage** : note de veille, fiche réponse pour les patients, atelier.

Partie B – Lire et juger

5. Le **danger** est la capacité d'un produit à causer un effet nocif (ici, un cancer), quelle que soit la dose. Le **risque** est la probabilité que cet effet survienne **aux doses réellement consommées**. Le **CIRC** évalue le danger : il classe l'aspartame en 2B, « peut-être cancérogène », car les preuves sont **limitées**. Le **JECFA** évalue le risque : il conclut qu'en dessous de **40 mg/kg/j** (la DJA), la consommation ne pose pas de problème de santé connu. Les deux avis ne se contredisent pas.

6. **Analyse de la cohorte**

Type d'étude : cohorte prospective (observation), avec un très grand effectif et un long suivi.

HR de 1,15 : chez les plus forts consommateurs d'aspartame, le risque instantané de cancer est **15 % plus élevé** que chez les non-consommateurs, en relatif. L'intervalle (1,03 à 1,28) **ne contient pas 1** : l'association est statistiquement significative, mais sa borne basse est proche de 1.

Part de participants avec un cancer : 3 358 / 102 865 = **3,3 %** sur l'ensemble du suivi. En ordre de grandeur, une hausse relative de 15 % sur un risque d'environ 3 % correspond à **environ un demi-point** de plus : la différence absolue est faible (calcul approché, qui ne remplace pas les résultats de l'étude).

Limites : étude d'**observation** (confusion résiduelle : les forts consommateurs peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au cancer) ; **causalité inverse** possible (des personnes en surpoids ou malades remplacent le sucre par des édulcorants) ; volontaires plus souvent des femmes, diplômées, intéressées par la santé (**sélection**) ; consommations déclarées.

Conclusion : l'étude montre une **association modeste** entre forte consommation d'aspartame et risque de cancer ; elle **ne prouve pas** que l'aspartame cause le cancer. Elle fait partie des éléments qui ont conduit le CIRC à parler de preuves « limitées ».

7. Calcul de la DJA

Mme L. : 1,5 × 300 = 450 mg par jour ; 450 / 72 = **6,25 mg/kg/j**, soit 6,25 / 40 = **15,6 % de la DJA**. Volume pour atteindre la DJA : 40 × 72 / 300 = **9,6 L par jour**.

Petit-fils : 0,5 × 300 = 150 mg ; 150 / 18 = **8,33 mg/kg/j**, soit **20,8 % de la DJA**.

Commentaire : les deux restent nettement sous la DJA (avec une teneur fictive) ; l'enfant, plus léger, atteint une part plus élevée avec trois fois moins de soda. Le vrai sujet n'est pas la toxicité : boire 1,5 L de soda par jour **entretient le goût du sucré** et remplace l'eau ; l'OMS ne recommande pas les édulcorants pour contrôler le poids. Pour l'enfant, le PNNS conseille l'eau.

8. Erreurs du document 2 : « **cancérigène** » alors que le CIRC dit « **peut-être** cancérogène » (groupe 2B, preuves limitées) ; « l'OMS le **confirme** » alors que le JECFA, comité de l'OMS et de la FAO, **maintient la DJA** ; « **prouve** » alors que la cohorte montre une **association** ; « les édulcorants **augmentent** le risque » sans chiffre ni différence absolue (HR 1,15, différence faible) ; « **Jetez vos sodas** » : conseil non fondé, sans alternative ; **aucune référence** ni date.

Partie C – Agir et communiquer

9. Valeur nutritionnelle des trois goûters

Goûter	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Habituel	330,2	5,2	62,6	49,7	6,0	0,9	0,32
« Édulcoré »	184,7	6,1	28,0	12,7	5,7	2,9	0,41
Atelier	238,3	8,0	24,4	21,6	10,2	4,5	0,13

Exemple de calcul (goûter habituel, énergie) : 125 × 103 / 100 + 20 × 438 / 100 + 330 × 34,5 / 100 = 128,75 + 87,6 + 113,85 = **330,2 kcal**.

Répartition de l'énergie (protéines, glucides, lipides) : habituel 6,3 %, 75,8 %, 16,5 % ; « édulcoré » 13,2 %, 60,6 %, 27,6 % ; atelier 13,5 %, 41,0 %, 38,4 % (le reste vient des fibres et des arrondis).

Commentaire : le goûter habituel apporte **49,7 g de sucres**, dont **27,3 g** par le seul soda (330 × 8,28 / 100), des sucres libres : pour 1 800 kcal par jour, 10 % de l'énergie représentent 45 g de sucres libres ; un seul goûter s'en approche. Le goûter **« édulcoré »** est le moins énergétique, mais il garde le **goût très sucré** et apporte peu de fibres. Le goûter de l'**atelier** apporte des sucres surtout **intrinsèques** (fruit) et du lactose, **4,5 g de fibres**, plus de protéines, des lipides de bonne qualité (amandes) et le moins de sel ; il apprend à apprécier un goût **moins sucré**, ce qui est l'objectif de l'atelier.

10. Coûts

Habituel : 0,35 + 20 × 2,40 / 1 000 + 0,45 = **0,85 €**. « Édulcoré » : 0,40 + 20 × 6,50 / 1 000 + 0,45 = **0,98 €**.

Atelier : 0,20 + (150 / 0,90) × 2,40 / 1 000 + 1 × 40 / 1 000 + 15 × 16 / 1 000 = 0,20 + 0,40 + 0,04 + 0,24 = **0,88 €**.

Budget des 3 ateliers : denrées 0,88 × 12 × 3 = **31,68 €** ; livrets 30 × 1,50 = **45,00 €** ; charges monétaires **76,68 €**. Contributions valorisées : (3 × 30 + 2 × 28 + 30) × 3 = 176 × 3 = **528,00 €**. Coût total : **604,68 €**, soit 604,68 / 30 = **20,16 € par participation**. Le goûter de l'atelier coûte à peu près le même prix que le goûter habituel, et moins que le goûter édulcoré.

11. Exemple : « **Édulcorants : ce qu'il faut savoir.** En juillet 2023, le CIRC a classé l'aspartame “peut-être cancérogène” (groupe 2B, preuves limitées) ; le même jour, le JECFA (FAO/OMS) a maintenu la dose journalière admissible de 40 mg/kg/j. Une cohorte française (NutriNet-Santé, *PLoS Medicine*, 2022) observe une association modeste entre forte consommation et cancer, sans preuve de cause. En mai 2023, l'OMS a recommandé de ne pas utiliser les édulcorants pour contrôler le poids (recommandation conditionnelle, hors personnes diabétiques). Ce que cela change : pas d'alerte sanitaire aux doses habituelles ; on conseille l'eau et la réduction progressive du goût sucré, plutôt que le passage du sucre aux édulcorants. Fiche réponse patients jointe. »
12. Exemple : « Madame, l'aspartame a été classé “peut-être cancérogène”, mais les preuves sont limitées, et à votre consommation vous restez bien en dessous de la dose jugée sans risque. Ce qui me gêne davantage, c'est 1,5 litre de soda par jour : il entretient l'envie de sucré. Et si on essayait de remplacer progressivement une partie par de l'eau, ou de l'eau pétillante avec un peu de citron ? » (environ 70 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la veille ; ordonner le cycle ; classer une information par forme de veille ; distinguer veille, recherche et bibliographie ; passer d'un axe à une question de veille ; analyser une demande de veille	19.1 à 19.6			
2	Distinguer push et pull ; choisir l'organisme de référence ; régler une alerte (bruit et silence) ; réduire le temps de lecture ; distinguer date du texte et date d'application ; choisir les sources d'une structure	19.7 à 19.12			
3	Remplir une fiche de la base ; gérer mots-clés et doublons ; construire une matrice de diffusion ; rédiger une note de veille ; calculer des indicateurs ; estimer le coût d'une veille	19.13 à 19.18			
4	Appliquer les critères de fiabilité ; noter des sites ; pratiquer la lecture latérale et SIFT ; repérer un graphique trompeur ; vérifier des références proposées par une IA ; repérer l'influence commerciale	19.19 à 19.24			
5	Décrire le circuit d'un article ; repérer une revue prédatrice ; utiliser un DOI ; distinguer erratum et rétractation ; rechercher des liens d'intérêts ; lire un preprint avec prudence	19.25 à 19.30			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
6	Classer les niveaux de preuve ; appliquer la grille de lecture ; comparer per protocole et intention de traiter ; calculer RR et différence de risque ; lire une méta-analyse ; ne pas transposer une étude animale	19.31 à 19.36			
7	Repérer le spin ; suivre une information jusqu'à la presse ; utiliser les fréquences naturelles ; lire un avis d'agence ; relier une recommandation à son grade ; répondre à une rumeur	19.37 à 19.42			
8	Rédiger une fiche de lecture et une synthèse ; présenter une veille à l'oral ; construire un plan de veille ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	19.43 à 19.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.